

分类号 R24

学校代号 10572

UDC 610 密级 公开

学 号 20196200045



广州中医药大学

Guangzhou University of Chinese Medicine

硕士学位论文

(以同等学力申请硕士学位)

反流性食管炎中医证型分布特点及 相关因素分析

学 位 申 请 人	范路娣
指 导 教 师 姓 名	杨小波
专 业 名 称	中西医结合临床
申 请 学 位 类 型	学术学位
论 文 提 交 日 期	2024 年 6 月

摘 要

目的:

反流性食管炎发病率升高与饮食、情绪诱发因素有关。因各地饮食与社会压力不尽相同,反流性食管炎中医证型分布及发病的诱发因素不尽相同,本研究通过回顾性病例系列分析与横断面调查相结合,运用统计学方法挖掘中医证型分布特点及其与胃镜分级、胃镜下合并病、饮食及情绪等因素的相关性,以期反流性食管炎的防治提供借鉴,为后续大样本研究提供参考。

方法:

本研究分两部分,第一部分回顾性病例系列分析,分析 2021 年 1 月至 2022 年 12 月反流性食管炎病例中医证型分布特点为第二部分横断面调查提供参考。第二部分通过收集 2023 年胃镜下诊断反流性食管炎患者相关信息(性别、年龄、病程、情绪、饮食偏嗜、胃镜分级、胃镜下合并病),运用统计学方法挖掘中医证型分布特点及其与胃镜分级、胃镜下合并病、饮食偏嗜及情绪等因素的相关性。

结果:

1. 回顾性分析 171 例 RE 病例,男性 110 例,女性 61 例,男女比例约为 1.80:1 ($P<0.05$) 差异具有统计学意义。年龄最小者是 20 岁,最大者是 70 岁,平均年龄为 (50.44 ± 13.147) 岁,青年组 52 例,中年组 64 例,老年组 55 例,各年龄组的分布差异不具有统计意义 ($P>0.05$)。中医证型分布由多到少依次为:脾虚湿热证 59 例、肝胃郁热证 42 例、气郁痰阻证 34 例、胆热犯胃证 12 例、瘀血阻络证 12 例、中虚气逆证 12 例,反流性食管炎中医证型最常见为脾虚湿热证、肝胃郁热证,差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。

2. 2023 年 1 月至 12 月符合入组反流性食管炎患者 127 人,男性 86 人、女性 41 人,男女比例约为 2.09:1,差异具有统计学意义 ($P<0.05$); 年龄最小者是 22 岁,最大者是 70 岁,平均年龄为 (52.06 ± 12.233) 岁,青年组 38 人,中年组 45 人,老年组 44 人,反流性食管炎各年龄组的发病率差异不具有统计学意义 ($P>0.05$); 病程分 4 等级,病程 <1 年的患者为 9 人,病程 1-3 年 58 人,病程 3-5 年 37 人,病程超过 5 年 23 人。病程超过 1 年的占 92.90%,差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。

首次发病 54 人,复发 73 人,差异不具有统计学意义 ($P>0.05$)。反流性食管炎无诱因发病 16 人,111 人单因素或多因素叠加发病,情绪失调 96 次 $>$ 饮食不节 88 次 $>$ 劳累过度 24 次,差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。127 例 RE 患者中无饮食偏嗜 8 人,有饮食偏嗜 119 人,多因素叠加统计,偏嗜冷饮 $>$ 偏嗜海鲜 $>$ 偏嗜辛辣 $>$ 偏嗜甜食 $>$ 喜饮浓茶 $>$ 喜饮酒,差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。

胃镜分级分布特点 A 级 97 例、B 级 24 例、C 级 4 例、D 级 2 例,差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。胃镜下合并病特点为部分病例同时合并多种其他胃部疾病,按

发生率由高到低排名依次为慢性非萎缩性胃炎 105 例、糜烂性胃炎 46 例、胃息肉 34 例、十二指肠球炎 23 例、慢性萎缩性胃炎 19 例、Barret 食管 10 例、胃溃疡 9 例、胆汁反流性胃炎 8 例，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。反流性食管炎有 1 种或多种临床症状出现，叠加统计，出现频率最高前 3 种依次为：反酸 69 次、口苦 53 次、腹部胀满 34 次，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。

中医证型分由多到少依次为：脾虚湿热证 49 例、肝胃郁热证 34 例、胆热犯胃证 13 例、瘀血阻络证 12 例、中虚气逆证 11 例、气郁痰阻证 8 例，反流性食管炎最常见为脾虚湿热证、肝胃郁热证，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。

RE 中医证型分布与性别、年龄、是否复发及胃镜分级关系，差异不具统计学意义 ($P>0.05$)；中医证型分布与病程差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。中医证型分布与诱发因素有关，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)，饮食不节、情绪失调均是脾虚湿热证、肝胃郁热证主要诱发因素，胆热犯胃证以情绪失调、劳累为主要诱发因素，气郁痰阻证诱发因素分布均匀，瘀血阻络证发病无明显诱因。中医证型分布与饮食偏嗜类型有关，肝胃郁热证主要与偏嗜冷饮、偏嗜辛辣、喜饮酒相关，脾胃虚热证主要与嗜食海鲜、偏嗜冷饮及甜食有主要关系，胆热犯胃证偏嗜辛辣、喜冷饮、喜浓茶，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。中医证型分布与居住广州时长关系具有统计学意义 ($P<0.05$)，居住 ≥ 10 年，常见气郁痰阻证、脾虚湿热证、瘀血阻络证为主，2-5 年胆热犯胃证为主。

中医证型分布与胃镜下合并病关系，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)，脾虚湿热证、肝胃郁热证、阻络证容易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎。

结论：

1.反流性食管炎发病男性多于女性，男性更应注意 RE 的预防，反流性食管炎的发病与年龄关系差异不具统计学意义，可能与样本量小有关。

2.反流性食管炎发病与饮食不节（饥饱无常）、情绪失调、劳累有相关性，为减少疾病发生可根据本地区诱发因素做好养护和调摄指导。

3.中医证型中脾虚湿热证、肝胃郁热证为最常见证型，此结果提示脾虚湿热证、肝胃郁热证可能为该地区常见类型。

4.本调查结果提示反流性食管炎中医证型分布与性别、年龄及胃镜分级相关性差异不具有统计学意义，可能与样本量小及地区差异有关。

5.中医证型分布与病程长短有相关性，脾虚湿热证、肝胃郁热证病程多在 1-5 年。中医证型分布与情绪失调、饮食不节及偏嗜、居住广州时长有相关性，饮食不节饥饱无常及饮食偏嗜（偏嗜冷饮、辛辣、海鲜）、情绪失调均是脾虚湿热证、肝胃郁热证的主要诱发因素，脾虚湿热证居住广州时长 ≥ 10 年居多，研究结果提示根据本地区居民常见的饮食偏嗜做好健康教育及饮食指导及做好情绪疏导，有助于减少疾病的发生，缩短疾病的病程。RE 中医证型分布与胃镜下合并病有相关性，脾虚

湿热证、肝胃郁热证均最容易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎，证型干预有可能减少合并病的发生，传统医学与现代医学相结合研究、互为补充为 RE 防治提供直观依据。

关键词：反流性食管炎；中医证型；诱因；相关性；

Characteristics of TCM syndrome distribution in reflux Esophagitis analysis of relevant factors

Specialty: Integrated Traditional Chinese and Western medicine major

Author: Ludi Fan

Tutor: Xiaobo Yang

Abstract

Objective

The increased incidence of reflux esophagitis is related to dietary and mood-induced factors. Because around the diet and social pressure is not the same, reflux esophagitis TCM syndrome distribution and inducing factors of the disease, this study through the retrospective case series analysis combined with cross-sectional survey, the use of statistical method mining TCM syndrome distribution characteristics and gastroscopy grading, gastroscopy disease, diet and emotional correlation, in order to provide

Methods

This study is divided into two parts, the first part of the retrospective case series analysis, analyzing the reverse from January 2021 to December 2022 Characteristics of TCM syndrome distribution in flow esophagitis cases provide reference for the second part of cross-sectional survey. The second part is through the collection Set relevant information on endoscopic diagnosis of reflux esophagitis in 2023 (gender, age, duration of disease, inducement, diet biasGastroenterology, gastroscopy grading, and gastroscopy combined diseases), using statistical methods to explore the distribution characteristics of TCM syndrome types and gastroscopyCorrelation between grade, endoscopic combination disease, dietary bias and emotional inducement.

Results

1. A retrospective analysis of 171 RE cases, 110 males and 61 females, a male to female ratio of about 1.80:1 ($P < 0.05$) was statistically significant. The youngest age was 20 years old, the oldest was 70 years old, and the average age was (50.44 ± 13.147) , 52 were in the youth group, 64 in the middle age group and 55 in the elderly group. The distribution difference ($P > 0.05$) was not statistically significant. The distribution of TCM syndrome ranged from more to less: 59 cases of spleen deficiency and dampness and heat syndrome, 42 cases of liver and stomach depression syndrome, 34 cases of qi stagnation, 12 cases of gastric syndrome, 12 cases of blood stasis obstruction syndrome, and 12 cases of middle deficiency and qi syndrome. The most common differences of TCM syndrome of reflux esophagitis were dampness and heat syndrome of spleen deficiency and liver and stomach depression syndrome, ($P < 0.05$).

2. 127 patients eligible for reflux esophagitis from January to December 2023, Of 86

males and 41 females, The male to female ratio is about 2.09:1, The difference was statistically significant ($P < 0.05$); The youngest age is 22, The oldest is age 70, The mean age was (52.06 ± 12.233) years, Of the 38 people in the youth group, Of 45 people in the middle-age group, Of 44 people in the elderly group, The difference in the incidence of reflux esophagitis was not statistically significant ($P > 0.05$); The disease course is divided into 4 grades, Nine patients with a disease duration of < 1 year, Disease course of 1-3 years, 58 people, Disease course of 3-5 years, 37 people, Course of disease for more than 5 years, 23 individuals. Course of disease for more than 1 year accounted for 92.90%, and the difference was statistically significant ($P < 0.05$).

54 first and 73 relapsed, not statistically significant ($P > 0.05$). Sixteen people had reflux esophagitis, 111 people with single or multiple factors, 96 mood disorders > 88 diet disorders > overwork 24 times, a statistically significant difference ($P < 0.05$). Among the 127 RE patients, 8 had no dietary bias and 119 had dietary bias. According to multiple statistics, cold drinks > seafood > spicy > sweet > drinking, the difference was statistically significant ($P < 0.05$).

Distribution characteristics of gastroscopy were 97 patients with grade A, 24 B, 4 C and 2 D, which was statistically significant ($P < 0.05$). Gastroscopic disease characteristics for some cases with a variety of other stomach diseases, according to the incidence from high to low ranking for 105 cases of chronic atrophic gastritis, 44 cases, gastric polyp, 23 cases of duodenal coccilitis, 19 cases of chronic atrophic gastritis, 10 cases, 9 cases of stomach failure, 8 cases of bile reflux gastritis, difference with statistical significance ($P < 0.05$). There were one or more clinical symptoms of reflux esophagitis. Combined with statistics, the top three symptoms with the highest frequency were: 69 times of acid reflux, 53 times of bitter mouth, and 34 times of abdominal distension. The difference was statistically significant ($P < 0.05$).

Distribution characteristics of gastroscopy were 97 patients with grade A, 24 B, 4 C and 2 D, which was statistically significant ($P < 0.05$). Gastroscopic disease characteristics for some cases with a variety of other stomach diseases, according to the incidence from high to low ranking for 105 cases of chronic atrophic gastritis, 44 cases, gastric polyp, 23 cases of duodenal coccilitis, 19 cases of chronic atrophic gastritis, 10 cases, 9 cases of stomach failure, 8 cases of bile reflux gastritis, difference with statistical significance ($P < 0.05$). There were one or more clinical symptoms of reflux esophagitis. Combined with statistics, the top three symptoms with the highest frequency were: 69 times of acid reflux, 53 times of bitter mouth, and 34 times of abdominal distension. The difference was statistically significant ($P < 0.05$).

RE TCM pattern and gender, age, recurrence and gastroscopy grade were not statistically significant ($P > 0.05$); the difference between TCM syndrome and disease course was statistically significant ($P < 0.05$). Distribution of traditional Chinese medicine syndrome related to inducing factors, differences with statistical significance ($P < 0.05$), diet,

mood disorders are spleen deficiency damp heat syndrome, liver stomach heat syndrome main inducing factors, bile heat gastric syndrome to emotional disorders, fatigue as the main inducing factors, gas depression phlegm resistance factors evenly distribution, blood stasis collateral disease no obvious cause. The distribution of TCM syndrome is related to dietary factors, liver and stomach fever is mainly related to cold drinks, spicy, and spleen and stomach deficiency is mainly related to seafood, cold drinks and sweet food. Bile fever is mainly related to spicy, cold drink and strong tea, and the difference is significant ($P < 0.05$). The relationship between the distribution of TCM syndrome type and the length of living in Guangzhou was statistically significant ($P < 0.05$). After 10 years, common qi depression and phlegm obstruction syndrome, spleen deficiency and dampness and heat syndrome, blood stasis obstruction syndrome, and gastric syndrome in 2-5 years.

The relationship between the distribution of TCM syndrome type and the complicated disease under gastroscopy was statistically significant ($P < 0.05$). The damp and heat syndrome of spleen deficiency, liver and stomach depression fever syndrome and collateral obstruction syndrome were easy to combine with chronic non-atrophic gastritis and erosive gastritis.

Conclusion

1. The incidence of reflux esophagitis is more in men than women, and men should pay more attention to the prevention of RE. The difference between the incidence of reflux esophagitis and age is not statistically significant, which may be related to the small sample size.

2. The incidence of reflux esophagitis is related to poor diet (hunger and satiety), emotional disorders and fatigue. In order to reduce the occurrence of disease, maintenance and adjustment guidance can be done according to the inducing factors in the region.

3. Distribution of TCM syndrome and heat syndrome are the most common types. This result indicates that spleen deficiency and heat syndrome and liver and stomach heat syndrome may be common types in this region.

4. The results of this survey indicate that the correlation difference between RE TCM syndrome type distribution and gender, age and gastroscopy grade is not statistically significant, and may be related to the small sample size and regional differences.

5. There is a correlation between the distribution of TCM syndrome type and the course of the disease, which affects the length of the course. The duration of the syndrome of spleen deficiency and dampness-heat and liver and stomach fever are mostly 1-5 years. Type of traditional Chinese medicine distribution and mood disorders, diet and bias, living in Guangzhou time correlation, spleen deficiency, liver stomach heat syndrome is the most common syndrome, diet not hungry and diet (cold drinks, spicy, seafood), mood disorders, spleen deficiency, liver stomach heat syndrome main inducing factors, spleen deficiency damp heat syndrome in Guangzhou 10 years, the results suggest according to the region residents common diet bias do health education and diet guidance and emotional guidance, help to reduce the occurrence of disease, shorten the course of the disease. There is a

correlation between RE syndrome distribution and gastroscopy complicated diseases. The syndrome of spleen deficiency and liver and stomach heat syndrome are the most likely to combine with chronic non-atrophic gastritis and erosive gastritis, and syndrome intervention may reduce the occurrence of complicated diseases. The combination of traditional medicine and modern medicine can provide intuitive basis for RE prevention and treatment.

Keywords: reflux oesophagitis; TCM syndrome type; inducement; relativity;

目 录

引言.....	1
第一章 文献研究	2
第一节 反流性食管炎现代医学研究	2
一、定义.....	2
二、流行病学.....	2
三、发病机制.....	2
四、临床表现.....	3
五、治疗.....	3
第二节 反流性食管炎祖国医学研究概况	4
一、病名.....	4
二、病因病机.....	5
三、辨证分型.....	6
四、治疗.....	6
第二章 临床研究	8
第一节 临床资料.....	8
一、病例来源.....	8
二、诊断标准.....	8
三、纳入、排除、剔除及脱落标准.....	9
四、技术路线.....	10
五、研究方法.....	10
第二节 研究结果.....	12
一、一般资料.....	12
二、171 例反流性食管炎病例性别、年龄、中医证型分布情况	12
三、127 例反流性食管炎患者中医证型分布与相关因素统计学分	
析	13
第三章 讨论.....	24
第一节 一般资料.....	24
一、反流性食管炎发病性别、年龄特点.....	24
二、反流性食管炎病程规律及复发情况.....	25
三、反流性食管炎发病诱因、饮食结构分析	25
四、反流性食管炎临床症状、胃镜分级、胃镜下合并病及中医证型	
分布	26
第二节 中医证型与相关因素	27
一、中医证型分布与性别、年龄关系.....	27

二、中医证型分布与病程、复发关系.....	27
三、中医证型与诱因、饮食及居住广州时长关系	28
四、中医证型分布与胃镜分级及胃镜下合并病关系	29
结语.....	30
参考文献.....	31
附录.....	34
附录 1.....	34
附录 2.....	35
附录 3.....	36
附录 4.....	38
附录 5.....	39
附录 6.....	41
附录 7 英文缩略语.....	42

引言

反流性食管炎（refluxesophagitis, RE）是一种胃、十二指肠内消化液与食糜等内容物反流入食道，内镜下可观察到食道黏膜发生相关损伤的疾病，属于胃食管反流病^[1]。其临床表现有烧心、反酸、嗝气等症状，部分患者常合并咳嗽、气喘、声音嘶哑等一系列食管外症状^[2]。流行病学资料显示，随着人们生活饮食习惯的改变及生活节奏的变化我国反流性食管炎发病率出现上升趋势。现代医学治疗手段主要以药物治疗为主，药物治疗不佳者则予以内镜及手术治疗。然而药物治疗不良反应发生率较高，停药复发率高，增加了医疗预算及患者的治疗负担，患者对手术治疗接受程度不高，部分新兴手术尚缺乏长期随访研究。

反流性食管炎是现代医学病名属胃食管反流病范畴，中医根据反酸、烧心、胸骨后灼痛、嗝气、反胃等症状，将其归属于“吐酸”、“胃脘痛”、“食管瘿”等范畴。中医认为其多因感受外邪、饮食不节、情志不遂、思虑太过致肝、胆、脾等脏腑功能失调，肝胆失于疏泄、脾失健运、胃失和降、胃气上逆，上犯食管，形成本病的一系列临床症状^[3]。

《黄帝内经》谓：“上工治未病，不治已病，此之谓也”。中医治未病法则未病先防，既病防变。未病先防，强调摄生，主张饮食规律、起居有节、调摄精神、避免过劳，预防疾病的发生；既病防变，既病后要积极防传变，早诊断、早治疗，减少并发症发生，及时控制病情，延缓疾病的进展，减少疾病的复发。

未病先防和既病防变的中医治则与反流性食管炎的发病演变高度符合。《素问·上古天真论》中指出保健摄生应起居有常，饮食有节，遵循自然规律。反流性食管炎中医证型分布调查可以更清晰了解证型分布特点并挖掘不同证型与诱发因素、饮食偏嗜、病程等因素的相关性，为疾病预防提供参考。

虽目前已有相关反流性食管炎中医证型研究文献，但相关研究结果显示不同地区中医证型分布存在差异，这可能与不同地区气候、饮食喜好、社会压力等不同有关。中医防治讲究因地制宜，我市生活节奏偏快，工作生活压力偏大，地处沿海气候多属湿热，人们偏爱海鲜、生冷、习惯服用清热解毒汤水等，本地病例是否有地域差异值得探讨。为了更好地做好反流性食管炎的预防，减少反流性食管炎的发病，本研究将对反流性食管炎中医证型分布进行调查并挖掘相关发病因素，以期提供更具体有效的起居饮食调护指导，为反流性食管炎的防治提供借鉴，同时期望为大样本量、多中心的研究提供参考。

第一章 文献研究

第一节 反流性食管炎现代医学研究

一、定义

反流性食管炎（reflux esophagitis，RE 属于胃食管反流病（gastroesophageal reflux disease，GERD）范畴，指胃内容物反流入食管引起的反流相关症状和（或）并发症的一种疾病，包括食管综合征和食管外综合征，属于慢性消化系统常见病^[4]，其特征性的临床表现有烧心、反酸、嗝气、上腹胀痛等症状，除此之外，部分患者常合并食管外症状咽痛、声音嘶哑、咳嗽等一系列食管外症状。食管外症状反流性咽喉炎、反流性咳嗽、反流性哮喘等气道症状，声带息肉、吸入性肺炎等气道并发症，心律失常、高血压、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征等终末器官效应等^[5]。

二、流行病学

反流性食管炎患病率高，且呈明显上升趋势，2006 年广东省社区人群中 GERD 的标化患病率为 2.3%^[6]。周金池^[7]团队做的 2000 年至 2019 年中国部分地区基于社区人群胃食管反流病患病率 Meta 分析显示中国人群 GERD 总体患病率 7.69%。目前全球范围内报告烧心或反流症状的发生频率 ≥ 1 次 / 周的比例约为 13%^[8]，严重影响人群的身心健康和生活质量。反流性食管炎增加了社会医疗负担，消化系统疾病治疗用药中前 5 位均为 GEER 治疗用药^[9]。GEER 的进展会诱发食管癌，GERD 引起的食管慢性炎症状态已被证实是食管腺癌最重要的危险因素，其中 BE 也是目前公认的食管腺癌的癌前病变^[10]。

三、发病机制

《中国胃食管反流病多学科诊疗共识 2022》认为反流性食管炎发生是多种因素、多部位均参与所致，食管裂孔疝可导致胃食管结合部抗反流屏障出现解剖性和功能性障碍，胃食管低动力状态是 GERD 的主要动力学特征，也是胃食管反流常见的诱发或加重因素，反流通道对反流物的敏感性和抵抗力，与 GERD 的症状和并发症发生密切相关^[11]。

（一）食管下括约肌功能异常

食管末端环形括约肌是一长约 1.0-3.5cm 的高压带，静息状态下的压力为 15-30mmHg，是有效抗反流的屏障。当该结构出现一过性松弛，括约肌高压带压力降低，食管与胃之间的压力差突破这一结构导致胃内容物反流至食管。食管下端括约肌一过性松弛、食管与胃之间的压力差共同形成反流性食管炎的发病因素。

（二）食管廓清功能下降

食管的正常蠕动以及碱性唾液的中和作用共同完成食管廓清功能，对食管粘膜起着保护作用。而当因食管出现病理性蠕动和或食管的蠕动减弱甚至消失时，食管的廓清功能下降，导致食管内酸性反流物停留时间延长，酸性反流物对食管粘膜的

损伤增加。

（三）胃、十二指肠功能异常

因胃排空延缓致胃扩张发生，增加 TLESR 发生机率，从而导致胃食管反流发生。幽门括约肌关闭不全，十二指肠内容物从幽门反流至胃，胃容积的增加可致反流性食管炎的发生风险增加；同时含胃酸的反流物损伤食管黏膜，食管黏膜受损食管的廓清功能下降。

（四）社会心理因素

胃肠道的功能状况与社会心理因素具有一定的相关性^[12]。生活、学习、工作压力的加重易产生不良情绪、出现焦虑抑制心理状态或突发应激情况体内胃肠神经递质的改变可诱发反流性食管炎的发生。疏导不良情绪、做好心理状态管理对功能性胃肠病疾病的发生和预防复发有积极正面的影响。

（五）生活方式、遗传因素及其他

吸烟、饮酒可使食管下括约肌、胃食管交界区压力下降，使反流性食管炎发生的机率增加。肥胖、咳嗽、腹部占位、大量腹水等使腹腔压力增大可导致胃肠排空障碍胃内容物增加，胃喷门部压力增加，增加反流风险，同时喷门部的不可逆性松弛可能是反流性食管炎反复的原因之一。

四、临床表现

《胃食管反流病中医诊疗专家共识（2023）》、《中国胃食管反流病多学科诊疗共识 2022》及朱生梁^[13]等多部文献认为反流性食管炎包括典型症状、不典型症状及食管外症状，其临床表现多样。

反流性食管炎的典型症状包括烧心和反流。不典型症状包括胸痛、上腹烧灼感、上腹胀或痛及嗝气犯酸等。食管外症状可伴随食管症状，部分为首发症状，其可包括咽喉不适或异物感、声音嘶哑、顽固性咳嗽、哮喘、牙侵蚀症等。并发症包括食管内及食管外，食管内常见上消化道出血、食管狭窄、巴雷特食管等，食管外并发症包括反流性咽喉炎、反流性咳嗽、反流性哮喘，声带息肉、吸入性肺炎心律失常、高血压等^[4]。

五、治疗

反流性食管炎治疗总目标是促进食管黏膜愈合、减轻症状、减少复发和避免并发症发生。治疗方式目前主要包含基础治疗、药物治疗、内镜下治疗、手术治疗和其他治疗。反流性食管炎的个体差异大，针对不同患者往往需要采用个体化治疗方案。

（一）基础治疗

生活方式调整是基础治疗手段，基础治疗是其他治疗的基石。生活方式的调整包括戒烟、酒、睡前 2-3 小时禁食、减少或避免诱发反流症状食物的食用（如茶、咖啡、碳酸饮料等）、抬高床头（约 30°），超重和肥胖减重和进行合理运动等。

（二）药物治疗

药物治疗包括抑酸剂、抗酸剂和胃肠促动药等。

1. 抑酸剂：目前临床上的抑酸剂主要包括 H₂ 受体阻断剂、PPI 和 PCAB。H₂

受体阻断剂通过竞争性可逆结合 H₂ 受体，抑制胃酸分泌。PPI 通过共价结合壁细胞活化态的质子泵，不可逆地抑制质子泵的活性，进而抑制胃酸分泌。PCAB 则通过竞争性结合活化和非活化态的质子泵中的钾离子，可逆地抑制质子泵的活性，进而抑制胃酸分泌。目前研究显示，PPI 在减轻反流症状、促进食管黏膜方面优于组胺 H₂ 受体阻断剂，而 PCAB 的疗效非劣于 PPI，PPI 和 PCAB 均为反流性食管炎初始治疗和维持治疗的首选药物^[14]。

2. 抗酸剂：常用的抗酸剂能升高胃内 pH 值，可直接快速中和胃酸，快速减轻反流、烧心症状，这类药包含氢氧化铝、铝碳酸镁、海藻酸盐等。

3. 胃肠促动药：胃肠促动药有多种，其作用机制各不同，甲氧氯普胺拮抗多巴胺 D₂ 受体，多潘立酮为外周性多巴胺 D₂ 受体拮抗剂，莫沙必利可选择性激动 5 羟色胺 4 受体，伊托必利具有阻滞多巴胺 D₂ 受体和抑制乙酰胆碱酯酶双重作用的，西尼必利激动 5 羟色胺 4 受体和同时抑制多巴胺受体，胃肠促动药联合抑酸药物对缓解症状可能有效，但促进食管黏膜愈合并未有证据。

（三）内镜下治疗

内镜下抗反流手术包括内镜下射频消融术、内镜下抗反流黏膜切除术、经口无切口胃底折叠术、经口内镜下贲门缩窄术等。

（四）外科治疗

外科抗反流手术包括各种角度的胃底折叠术、磁环括约肌增强术。

（五）其他治疗

经皮电刺激是一种通过表面电刺激穴位的无创治疗方法，但目前长期疗效需进一步确定和同时在不良反应方面目前仍未有更多更全面的数据。

第二节 反流性食管炎祖国医学研究概况

一、病名

反流性食管炎是现代医学病名，中医无相应的病名，根据其主要临床表现反酸、烧心、嗝气、反胃、口苦、咽喉不适、胸骨后灼痛等症状，归属于“吐酸”、“呕苦”、“吞酸”、“嘈杂”、“食管瘁”等范畴。

“吐酸”首见于我国第一部医学著作《黄帝内经》在《素问·至真要大论》中指出：“诸呕吐酸……皆属于热”。谓“少阳之胜，热客于胃，烦心心痛，目赤欲呕，呕酸善饥”这是对吐酸病因的最早认识。隋代巢元方在其《诸病源候论》中将其称为“隐醋”：“隐醋者，由上焦有停痰，脾胃有宿冷，故不能消谷，谷不消则胀满而气逆，所以好噯而吞酸，气息醋臭”。“嘈杂”一词见于宋代陈自明《妇人

良方》：“妇人嘈杂，此脾胃郁火。”2009年《胃食管反流病中医诊疗共识意见》（深圳）中，以“食管瘿”、“吐酸病”作为胃食管反流病的中医病名。因与胃食管反流病的解剖学概念、病理生理基础相近，其病位在食管，部分患者仅表现为烧心、咽喉不适、胸前区不适等症状；难治性胃食管反流病患者的发病不仅仅与酸反流相关，与多种因素相，因此以“食管瘿”作为中医病名基本上可反映本病的病位、病因病机与主症^[15]。

二、病因病机

（一）病因

《临证备要·吞酸》：“胃中泛酸，嘈杂有烧灼感，多因于肝气犯胃。”《素问·通评虚实论篇》曰：“膈塞闭绝，上下不通，则暴忧之病也。”《太平圣惠方·第五十卷》记录“寒温失宜，食饮乖度，或恚怒气逆，思虑伤心致使阴阳不和，胸膈痞塞。故名膈气也。”噎膈的发病与进食、情志、肝气不舒相关，《严氏济生方》中提到，“若禀受怯弱，饥饱失时，或过餐五味，鱼腥乳酪，强食生冷瓜果菜，停蓄胃脘，遂结宿滞，轻则吞酸呕恶”。

南宋时期严用和认为先天禀赋不足、嗜吃油腻、生冷，饮食不节均可导致本病的发生。《景岳全书》中写道：“凡肌表暴受风寒，则多有为吞酸者……寒气一入，则胃中阳和之气被抑不舒，所以滞浊随见而即刻见酸。”古代医家对本病的发病原因有多层次多方面的认识，认为本病的病因与感受外邪、情志不畅、饮食无度，饮食偏嗜密切相关。

李开杨团队^[16]对中医专家诊治反流性食管炎的75篇文献分析得出反流性食管炎病理因素共有25个，其中实性17个，包括痰、瘀血、气滞等，虚性病理因素4个，包括虚、气虚、阴虚、阳虚，不便分类的有湿、寒、寒湿、阴火4个。《胃食管反流病中医诊疗专家共识意见（2017）（2023）》两版专家共识认为外邪入侵、寒热客胃；思虑过度、情志不遂；饮食不节，偏嗜饮料、肥甘厚腻无度、烟酒不节；脾胃虚弱、中虚气逆以及素罹胆病，胆热犯胃等为主要病因^[17]。

（二）病位

病位在食管和胃，与肝、胆、脾等脏腑功能失调密切相关^[18]。

（三）病机

反流性食管炎的基本病机为肝胃不和、胆热犯胃、气滞血瘀、脾胃虚弱等多种原因致胃失和降，胃气上逆上伐食管致胃食管反流而发病^[19]。肝气不舒、胆气不利，肝胆失于疏泄、脾失健运、肺失宣肃、胃失和降、胃气上逆上犯于食管，导致本病的一系列临床症状。禀赋不足、脾胃虚弱、胃阴不足为胃食管反流病发病基础，肝郁气滞，久而化热，横犯于胃，肝胃不和，则肝胃郁热；胆气不舒胆腑郁而化热，则胆热犯胃；脾胃虚弱或脾虚湿滞郁而化热，脾气不升，胃气不降，升降失调，则胃气上逆；胸阳不振，清气当升不升，浊阴上伐，痰气痹阻胸膈；胃气上逆，肺失

宣肃，则气逆咳喘。久病则虚，津液耗伤，则胃失濡养，胃阴不足。气病及血，久病则虚可因虚致瘀或气滞血瘀。本病病理因素虚实皆有，虚责之脾气虚、胃阴虚，实责之痰、湿、热、气、郁、瘀。反流性食管炎病机特点可概况为逆、热、郁^[20]。

三、辨证分型

相关学者^[21-24]的研究中证实 RE 的中医证型外与饮食偏嗜、情志、肥胖，内与脾胃虚弱、素体禀赋不足、久病体虚等有关，不同中医证候食管动力有不同表现，中虚气逆、气郁痰阻证与食管运动不协调相关，胆热犯胃、肝胃不和证与食管、下食管括约肌动力不足相关。

由陈可冀^[25]等主编的《实用中西医结合内科学》将反流性食管炎分为 4 个中医证型：胃失和降证、胃阴不足证、肝气犯胃证、脾胃虚寒证。王万卷等^[26]研究得出反流性食管炎 3 个常见中医证型为脾虚气滞证、肝胃不和证、肝郁脾虚证。师宁^[27]等总结近 30 年有关反流性食管炎辨证分型的文献，发现使用频率最高的是肝胃郁热型、脾胃湿热型、肝胃不和型、脾胃虚寒型、肝胃气滞证、气带血瘀证。

《胃食管流病中医诊疗专家共识意见（2017）》中将本病分为肝胃郁热证、脾虚湿热证、胆热犯胃证、瘀血阻络证、气郁痰阻证、中虚气逆证共 6 种证型。

《胃食管反流病中医诊疗专家共识（2023）》对 2017 年专家共识做了修改，中医证型调整为肝胃郁热证、胆火上逆证、气郁痰阻证、中虚气逆证、脾虚湿热证、胸阳不振证、胃阴不足证。随着科研及临床的积累，近代、现代各医家学者对反流性食管炎的认识将更深入及更全面。

四、治疗

中医药治疗包括非药物治疗、药物治疗，常常综合运用，对该病进行治疗，积累了丰富经验。

曹雨佳^[28]运用针灸与口服奥美拉唑肠溶胶囊对照观察针灸治疗反流性食管炎的临床疗效，结论提示针灸治疗反流性食管炎具有较好疗效，优于常规西药治疗。宋博媛^[29]对反流性食管炎的治疗进行数据挖掘得出关于反流性食管炎治疗的文献 326 篇，证型 54 种，方剂 326 首，药物类别 18 种，药物种类 157 种，推出新方 6 首。李良玉^[30]运用针刺、中药内服、微波热疗综合治疗手段治疗反流性食管炎 53 例与对照组 52 例运用奥美拉唑肠溶片联合枸橼酸莫沙必利片治疗，其实验结果显示治疗组在治愈、显效率、复发率比治疗组好。林益群^[31]用黄连温胆汤加味与奥美拉唑作对照治疗 63 例反流性食管炎患者，发现黄连温胆汤治疗反流性食管炎 32 例，复发率为 20.69%，奥美拉唑治疗的对照组（30 例）复发率 66.67%，两组差异具有统计学意义。许凤莲^[32]用一贯煎加味治疗 60 例 RE 患者，总有效率为 93.3%，优于 60 例西药组（奥美拉唑、吗丁啉）75.0%，两组差异具有统计学意义。李榕萍^[33]中药辨证治疗反流性食管炎 70 例，效果优于单纯使用西药。付丽英^[34]将 80 例反流性食管炎进行对照组采用雷尼替丁胃复安治疗，观察组采用舒肝和胃汤治疗，实验结果显示实验组

比对照组治疗总有效率更高、复发率更低。何恽晔^[35]的研究表明疏肝和胃汤治疗反流性食管炎效果显著。周晓明^[36]的实验结论提示西药联合加味连苏饮辅助治疗反流性食管炎（湿热蕴中证）疗效显著，可有效改善患者临床症状及内镜分级评分。王振民等^[37]自拟三行汤治疗反流性食管炎结论提示三行汤治疗组比奥美拉唑治疗组疗效更佳。据陶紫晶^[38]统计 1988-2021 年有 2110 篇关于中医药治疗胃食管反流病的相关中文期。朱峰团队^[39]、徐辉^[40]、徐庆团队^[41]等关于中医药治疗反流性食管炎分别可促进胃排空，调节 IL-17、IL-23、PGE2 的表达水平，降低复发率；能够升高患者的 MTL 水平；能促进患者食管内 pH 值及动力学恢复，并改善其血清 CGRP、IL-17 表达水平均为中医药治疗反流性食管炎提供了确切的现代医学依据。

宋凌^[42]对反流性食管炎患者的危险因素及生活方式进行干预，发现通过饮食调整、生活方式的调整、心理干预、运动调养可减轻患者的临床症状，联合药物治疗起到标本兼治效果。

《胃食管流病中医诊疗专家共识意见（2017）》共识中提出 6 个中医证候分型^[20]：

- 1.肝胃郁热证，疏肝泄热，和胃降逆，柴胡疏肝散《景岳全书》合左金丸《丹溪心法》加减；
- 2.胆热犯胃证，清化胆热，降气和胃，小柴胡汤《医方集解》合温胆汤《备急千金要方》加减；
- 3.气郁痰阻证，开郁化痰，降气和胃，半夏厚朴汤《金匱要略》；
- 4.中虚气逆证，疏肝理气，健脾和胃，旋覆代赭汤《伤寒论》合六君子汤《医学正传》；
- 5.脾虚湿热证清化湿热，健脾和胃，黄连汤《伤寒论》；
- 6.瘀血阻络证，活血化瘀，行气止痛，血府逐瘀汤《医林改错》。

《胃食管反流病中医诊疗专家共识（2023）》对 2017 年专家共识做了修改，增加了胸阳不振证，通阳宣痹，降气化痰，枳实薤白桂枝汤（瓜蒌薤白桂枝汤）合小陷胸汤加减。胃阴不足证，滋养胃阴，和胃降逆，益胃汤加减。

第二章 临床研究

第一节 临床资料

一、病例来源

本研究分两部分，第一部分回顾性病例系列分析，第二部分横断面调查。

1. 第一部分选取广州市第十二人民医院消化内镜工作站与电子病历系统作为数据库，提取 2021 年 1 月至 2022 年 12 月胃镜下诊断反流性食管炎病例。

2. 第二部分选取 2023 年 1 月至 2023 年 12 月广州市第十二人民医院通过胃镜检查并诊断为反流性食管炎的病人为研究对象。

二、诊断标准

（一）西医诊断标准

参照中华医学会消化病分会中国胃食管反流病共识意见专家组制定的《2020 年中国胃食管反流病专家共识意见》[2]:

1. 临床症状：反流性食管炎最常见的典型症状是烧心、反流，常见的不典型症状包括胸痛、上腹烧灼感、上腹痛、上腹胀、嗝气等。

2. 胃镜检查是诊断 RE 的主要方法，分级参照国际通用的洛杉矶 LA 分类法分为 A、B、C、D 四级。

A 级：食管有一个或一个以上黏膜破损，长径 $\leq 5\text{mm}$ （局限于 1 个黏膜皱襞内）。

B 级：一个或一个以上黏膜破损，长径 $> 5\text{mm}$ （局限于 1 个黏膜皱襞内），且病变没有融合。

C 级：黏膜破损有融合，但 $< 75\%$ 的食管周径。

D 级：黏膜破损相互融合范围累积 $\geq 75\%$ 的食管周径。

（二）中医辨证标准

反流性食管炎的中医证型诊断标准：参照中华中医药学会脾胃分会《胃食管反流病中医诊疗专家共识意见（2017）》分 6 个证型[3]。

1. 肝胃郁热证

（1）主症：①烧心 ②反酸

（2）次症：①胸骨后灼痛 ②胃脘灼痛 ③脘腹胀满 ④嗝气或反食 ⑤易怒 ⑥易饥

（3）舌脉：①舌红，苔黄：②脉弦

2. 胆热犯胃证

（1）主症：①口苦咽干 ②烧心

（2）次症：①胁肋胀痛 ②胸背痛 ③反酸 ④嗝气或反食 ⑤心烦失眠 ⑥易饥

(3) 舌脉: ①舌红, 苔黄腻 ②脉弦滑

3. 气郁痰阻证

(1) 主症: ①咽喉不适如有痰梗 ②胸膈不适

(2) 次症: ①暖气或反流 ②吞咽困难 ③声音嘶哑 ④半夜呛咳

(3) 舌脉: ①舌苔白腻 ②脉弦滑

4. 瘀血阻络证

(1) 主症: ①胸骨后灼痛或刺痛

(2) 次症: ①后背痛 ②呕血或黑便 ③烧心 ④反酸 ⑤暖气或反食 ⑥胃脘刺痛

(3) 舌脉: ①舌质紫暗或有瘀斑 ②脉涩

5. 中虚气逆证

(1) 主症: ①反酸或泛吐清水 ②暖气或反流

(2) 次症: ①胃脘隐痛 ②胃痞胀满 ③食欲不振 ④神疲乏力 ⑤大便溏薄

(3) 舌脉: ①舌淡, 苔薄 ②脉细弱

6. 脾虚湿热证

(1) 主症: ①餐后反酸 ②饱胀

(2) 次症: ①胃脘灼痛 ②胸闷不舒 ③不欲饮食 ④身倦乏力 ⑤大便溏滞

(3) 舌脉: ①舌淡或红, 苔薄黄腻 ②脉细滑数

证型确定: 具备以上主症 2 项, 加次症 2 项, 参考舌脉, 即可诊断证型。

无症状者以舌脉象+胃纳情况+大便情况诊断证型。

三、纳入、排除、剔除及脱落标准

(一) 纳入标准

1. 符合反流性食管炎的西医及中医诊断标准。

2. 性别不限, 18 岁≤年龄≤70 岁。

3. 患者自愿参与本项目问卷调查并签署知情同意书, 回顾性分析所收集病例经医院伦理委员会备案讨论并通过。

4. 居住广州 2 年以上者 (适用于横断面调查部分)。

(二) 排除标准

1. 排除消化道梗阻、肝硬化、食管及胃肠道肿瘤, 既往有胃食管手术者。

2. 排除肝、肾、心、脑及血液系统有严重的原发性疾病者。

3. 排除心血管疾病心急性冠脉综合征、心肌梗死等心血管疾病及肺部疾病所引起的胸闷、胸骨后不适者。

4. 排除精神疾病患者。

5. 排除妊娠期或哺乳期妇女。

6. 排除近一个月有服用 PPI、PCAB 及其他制酸药或及抗生素等药物者。

7.排除复杂中医证型，如两型及三型同时出现者或没有主次之分者。

（三）剔除标准

1.因不符合诊断标准、纳入标准而被误纳入者。

2.缺项超过 20%资料收集不完整者。

3.剔除两次中医证型不一致者（回顾性分析部分，电子病历所记录中医证型与研究组二次辨证证型不一致者）。

（四）脱落标准

1.因各种原因导致未能坚持完成本研究的问卷调查者。

2.无任何理由要求退出调查者。

3.无论是何种原因导致脱落，对脱落者应尽量随访同时做好相关记录，保存好原始数据。

四、技术路线

1.选取广州市第十二人民医院消化内镜工作站与电子病历系统作为数据库，提取 2021 年 1 月至 2022 年 12 月胃镜下诊断反流性食管炎病例，通过身份证号作关联从电子病历系统提取相应中医证型、临床症状、舌脉象信息→符合纳入标准、排除标准→课题组医师参照记录信息按诊断标准二次辨证分型→剔除病历记录证型与二次辨证结果不一致病例，两次证型一致病例采纳入组（对于多次诊疗，治疗后证型有变化者采纳与胃镜检查同次就诊记录中医证型作辨证对比）→录入并整理数据→统计分析评价。

2.2023 年 1 月-2023 年 12 月期间对广州市第十二人民医院病房及门诊经胃镜确诊为反流性食管炎患者严格参照纳入排除标准筛选入组→收集患者相关信息（病程、诱因、饮食偏嗜、临床症状），同时采集胃镜检查结果→课题组医师讨论及辨证分析得出中医证型→数据录入、整理→统计分析评价。

五、研究方法

回顾性分析部分

（一）数据筛查及提取：消化内镜工作站与电子病历系统作为数据库，提取 2021 年 1 月至 2022 年 12 月胃镜下诊断反流性食管炎病例，通过身份证号作关联从电子病历系统提取相应中医证型、临床症状、舌脉象信息。

（二）入组及证候筛查：课题组医师对所提取数据整理并严格参照纳入排除标准筛选入组，同时进行二次辨证讨论剔除病历记录证型与二次辨证结果不一致病例，两次证型一致病例采纳入组（对于多次诊疗，治疗后证型有变化者采纳与胃镜检查同次就诊记录中医证型作辨证对比）。

（三）整理数据及统计分析：运用 Excel 软件对收集到的数据进行录入整理，所有数据不得随意涂改，录入结束后对所有数据进行核对，确保无差错。统计学方法同横断面调查部分。

横断面调查部分

（一）调查表的设计

查阅相关文献，根据研究目的结合导师及团队成员临床经验共同制定《反流性食管炎患者临床资料登记表》，具体见附录 2

（二）调查表的内容

1. 收集患者一般资料（包括姓名、年龄、性别、在广州居住年数、联系电话等）；
2. 收集患者病程、诱因、饮食偏嗜等情况，记录胃镜下表现（包括反流性食管炎分级、胃镜下合并病）；
3. 收集患者的四诊资料，中医辨证分型在导师指导下由两名及以上主治医师以上的人员讨论确认。

（三）调查步骤

对门诊及病房在胃镜下确诊为反流性食管炎的患者，严格依据纳入标准及排除标准进行病例的筛选，对符合所有标准患者进行知情告知，获得同意后签署知情同意告知书，采用问卷调查的形式收集患者一般信息及临床资料，调查表均由研究者统一填写。

（四）病例筛选质量把控

当临床调查表确定之后，由导师对参与调查者进行研究课题组内 SOP 培训，确保筛选调查对象严格依照诊断标准及纳排标准，根据标准填写统一的调查表，确保所收集的临床数据真实可靠，降低调查人员自身主观选择的偏倚。

（五）数据整理

运用 Excel 软件对收集到的数据进行录入整理，所有数据不得随意涂改，录入结束后对所有数据进行核对，确保无差错。

（六）统计学分析

统计学分析借助 SPSS26.0 统计软件包进行描述统计，计数资料采用卡方检验，若出现样本量小于 40，或者理论期望值小于 5 的单元格达到总单元格的 20%及以上，或者出现任意一个单元格理论期望值小于 1 时，改用 Fisher 确切概率法检验，计量资料采用 SW 检验符合正态分布，采用平均值±标准差 ($\bar{x} \pm S$) 进行描述；不符合正态分布，采用中位数（25%位数，75%位数）表示；对于等级资料则采用 Kruskal-WallisH 秩和检验， $P < 0.05$ 具有统计学意义，比较结果若具有统计学差异时，再进行两两比较，并采用 Bonferroni 进行校正，校正调整后的 P 值，仍以 $P < 0.05$ 具有统计学差异。

第二节 研究结果

一、一般资料

（一）从广州市十二人民医院消化内镜工作站与电子病历系统检索筛查 2021 年 1 月至 2022 年 12 月胃镜下诊断反流性食管炎病例，符合纳入排除标准病例 171 例。

（二）收集 2023 年 1 月至 2023 年 12 月广州市第十二人民医院病房及门诊经胃镜确诊为反流性食管炎患者，符合纳入标准患者共 127 人。

二、171 例反流性食管炎病例性别、年龄、中医证型分布情况

从广州市十二人民医院消化内镜工作站与电子病历系统检索筛查 2021 年 1 月至 2022 年 12 月胃镜下诊断反流性食管炎病例，符合纳入排除标准病例 171 例，现统计分析如下：

（一）性别、年龄分布情况

本次筛选反流性食管炎病例 171 例，男女性别分布如表 1-1，男性 110 例（64.30%），女性 61 例（35.70%），男女比例约为 1.80：1，采用拟合优度检验（ $\chi^2=14.04$ ， $P=0.000$ ， $P<0.05$ ），反流性食管炎男性发病比女性高，差异具有统计学意义。

表 1-1 性别分布情况

性别	例数	百分比（%）
男	110	64.30
女	61	35.70
总计	171	100.00

年龄分布如表 1-2，年龄最小者 20 岁，最大者 70 岁，平均年龄为（50.44±13.147）岁。年龄分成三组：18 岁~44 岁（青年组），45 岁~59 岁（中年组），≥60 岁（老年组），青年组 52 例（30.40%），中年组 64 例（37.40%），老年组 55 例（32.20%），卡方检验 $\chi^2=1.368$ ， $P=0.504$ ， $P>0.05$ ，反流性食管炎发病与各年龄组相关性，差异不具有统计学意义。

表 1-2 年龄分布情况

年龄（岁）	例数	百分比（%）
18-44	52	30.40
45-59	64	37.40
≥60	55	32.20

（二）中医证型分布

中医证型分布由多到少依次为：脾虚湿热证、肝胃郁热证、气郁痰阻证、胆热犯胃证、瘀血阻络证、中虚气逆证。脾虚湿热证 59 例（34.50%），肝胃郁热证 42 例（24.60%），气郁痰阻证 34 例（19.90%），胆热犯胃证 12 例（7.00%），瘀血阻

络证患者 12 例（7.00%），中虚气逆证 12 例（7.00%），经 χ^2 检验 $\chi^2=68.754$ ， $P=0.000$ ， $P<0.05$ ，反流性食管炎中医证型最常见为脾虚湿热证、肝胃郁热证，差异具有统计学意义。

表 1-3 中医证型分布情况

证型	例数	百分比（%）
脾虚湿热证	59	34.50
肝胃郁热证	42	24.60
气郁痰阻证	34	19.90
胆热犯胃证	12	7.00
中虚气逆证	12	7.00
瘀血阻络证	12	7.00
总计	171	100.00

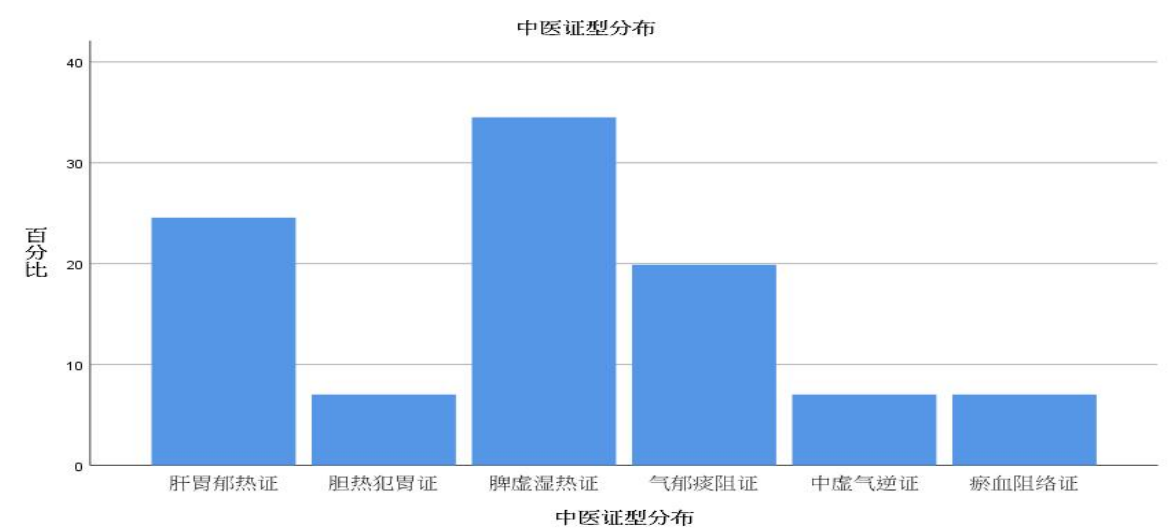


图 1-1 中医证型分布图

三、127 例反流性食管炎患者中医证型分布与相关因素统计学分析

收集 2023 年 1 月至 2023 年 12 月广州市第十二人民医院病房及门诊经胃镜确诊为反流性食管炎患者，符合纳入标准患者共 127 人，现统计学分析如下

（一）性别、年龄分布情况

本次符合入组标准 127 人，男女性别分布如表 2-1，男性 86 人（67.70%），女性 41 人（32.30%），男女比例约为 209：1，采用拟合优度检验（ $\chi^2=15.145$ ， $P=0.000$ ， $P<0.05$ ），反流性食管炎男性发病比女性高，差异具有统计学意义。

表 2-1 性别分布情况

性别	人数	百分比（%）
男	86	67.70
女	41	32.30
总计	127	100.00

年龄分布如表 2-2，年龄最小者是 22 岁，最大者是 70 岁，平均年龄为

(52.06±12.233) 岁。青年组 (18 岁~44 岁) 38 人 (29.92%)，中年组 (45 岁~59 岁) 45 人 (35.43%)，老年组 (≥60 岁) 44 人 (34.64%)，卡方检验 $\chi^2=0.677$ ， $P=0.713$ ， $P>0.05$ ，本次调查各年龄组反流性食管炎的发病率差异不具有统计学意义，结果与部分文献有差异，不排除与地域差异及样本量小有关。

表 2-2 年龄分布情况

年龄 (岁)	人数	百分比 (%)
18-44	38	29.92
45-59	45	35.43
≥60	44	34.64

(二) 病程、复发病规律

在 127 例反流性食管炎患者中，病程分布如表 2-3，病程<1 年 9 人 (7.10%)，病程 1-3 年 58 人 (45.70%)，病程 3-5 年 37 人 (29.10%)，病程超过 5 年 23 人 (18.10%)。病程超过 1 年的占 92.90%，经拟合优度卡方检验得出如下结论： $(\chi^2=41.283, P=0.000, P<0.05)$ 差异具有统计学意义，提示反流性食管炎病程迁延难愈。

表 2-3 病程分布情况

病程	人数	百分比 (%)
≥5 年	23	18.10
3-5 年	37	29.10
1-3 年	58	45.70
<1 年	9	7.10
总计	127	100.00

注：1-3 年：1 年≤病程<3 年；3-5 年：3 年≤病程<5 年

如表 2-4 可见，127 例反流性食管炎患者中，首次发病 54 例，复发 73 例，首发占比 42.50%，复发占比 57.50%，经拟合优度卡方检验得出如下结论： $(\chi^2=28.43, P=0.092, P>0.05)$ 差异不具有统计学意义。

表 2-4 127 例 RE 患者是否复发分布情况

	例数	百分比 (%)
复发	73	57.50
首发	54	42.50
总计	127	100.00

(三) 诱因、饮食偏嗜分布情况

收集 2023 年 127 例 RE 患者发病诱因如表 2-5，无诱因发病 16 人，111 人单因素或多因素叠加发病，叠加统计得出下表，劳累过度 24 次 (10.70%)，饮食不节发病 88 次 (39.30%)，因情绪失调发病 96 次 (42.90%)，经拟合优度卡方检验得出如下结论： $(\chi^2=93.714, P=0.000, P<0.05)$ 差异具有统计学意义，提示反流性食管炎发病多有外因影响，情绪失调、饮食不节 (饥饱无度) 是常见的诱发因素。

表 2-5 2023 年 RE 患者诱因分布情况

诱因	频次	百分比 (%)
无诱因	16	7.10
劳累过度	24	10.70
饮食不节	88	39.30
情绪失调	96	42.90
总计	224	100.00

2023 年 127 例 RE 患者饮食偏嗜分布如表 2-6 及图 2-1 所示，其中无饮食偏嗜 8 人，有饮食偏嗜 119 人。统计获得饮食因素共 229 个，去除无饮食偏嗜 8 个（3.50%）对有饮食偏嗜进行多因素叠加统计得出下表，高到低依次为：偏嗜冷饮（24.60%）、偏嗜海鲜（21.40%）、偏嗜辛辣（19.70%）、偏嗜甜食（12.70%）、喜饮浓茶（10.00%）、喜饮酒（7.90%）。经 Fisher 检验得出如下结论：（ $\chi^2=59.345$ ， $P=0.000$ ， $P<0.05$ ）差异具有统计学意义，提示发病多存在饮食偏嗜，且饮食偏嗜中冷饮、海鲜为较高占比。

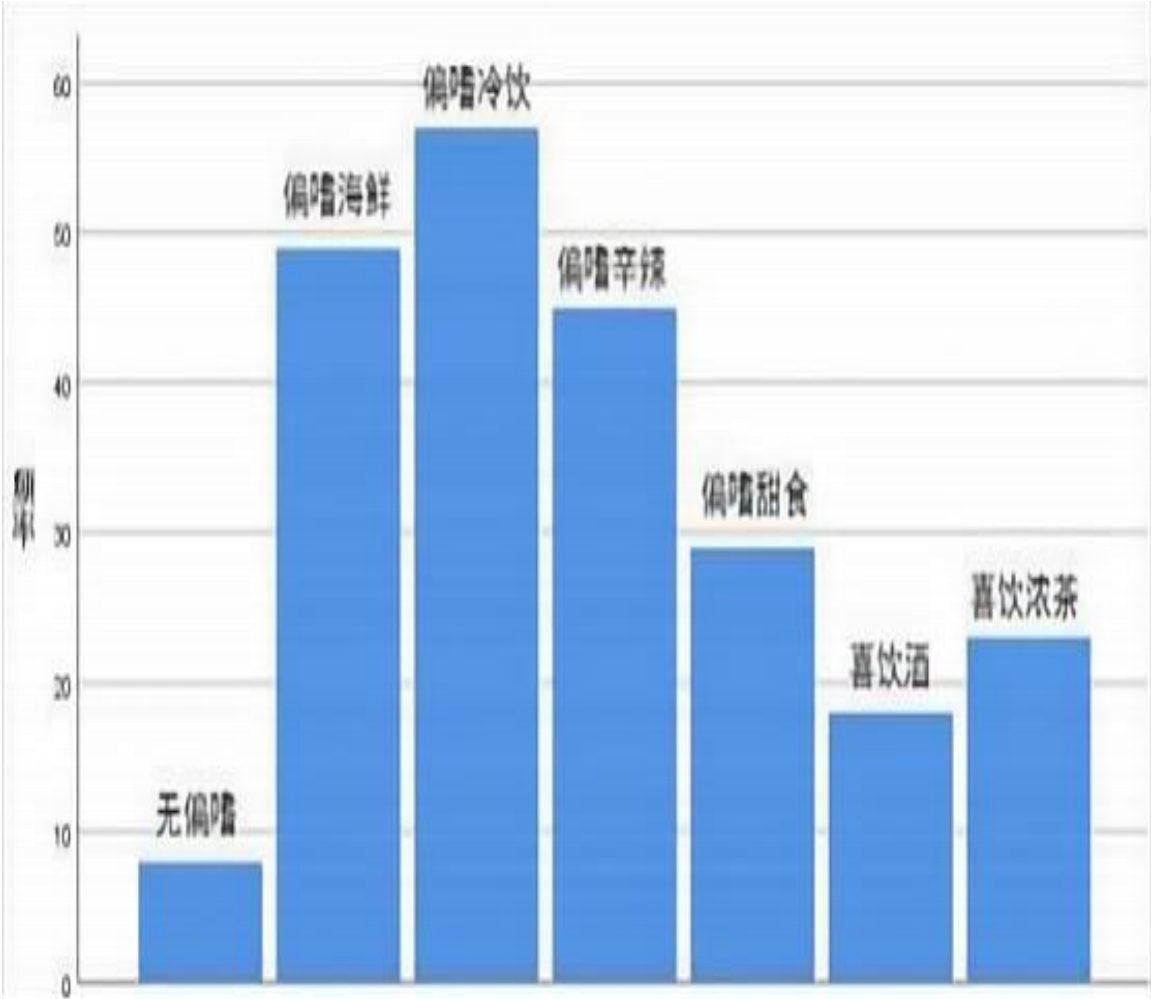


图 2-1 2023 年 RE 患者饮食偏嗜分布图

表 2-6 2023 年 RE 患者饮食偏嗜分布情况

饮食偏嗜	个数	百分比 (%)
无偏嗜	8	3.50
偏嗜海鲜	49	21.40
偏嗜冷饮	57	24.60
偏嗜辛辣	45	19.70
偏嗜甜食	29	12.70
喜饮浓茶	23	10.00
喜饮酒	18	7.90
总计	229	100.00

(四) 胃镜分级、胃镜下合并病分布情况

127 例 RE 患者胃镜分级分布如表 2-7 所示, A 级 97 例 (76.40%) B 级 24 例 (18.90%) C 级 4 例 (3.10%) D 级 2 例 (1.60%)。经拟合优度卡方检验得出如下结论: ($\chi^2=18.8118$, $P=0.000$, $P<0.05$) 差异具有统计学意义说明胃镜分级主要以 A 级为主, RE 患者食管黏膜损伤以轻度居多, 此结果与部分文献研究结果有差异, 不排除与此次调查样本量偏小有关。

表 2-7 127 例 RE 患者胃镜分级分布情况

分级	例数	构成比 (%)
A 级	97	76.40
B 级	24	18.90
C 级	4	3.10
D 级	2	1.60
总计	127	100.00

127 例反流性食管炎中胃镜下合并其他胃食管疾病分布情况如表 2-8, 按个案率由高到低排名依次为慢性非萎缩性胃炎 105 例 (82.70%)、糜烂性胃炎 46 例 (36.20%)、胃息肉 34 例 (26.80%)、十二指肠球炎 23 例 (18.10%)、慢性萎缩性胃炎 19 例 (15.00%)、Barret 食管 10 例 (7.90%)、胃溃疡 9 例 (7.10%)、胆汁反流性胃炎 8 例 (6.30%), 部分病例合并多种其他胃部疾病。

调查结果提示提示反流性食管炎合并病最常见为慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃息肉, 经拟合优度卡方检验得出如下结论: ($\chi^2=44.4260$, $P=0.000$, $P<0.05$) 差异具有统计学意义。

表 2-8 127 例反流性食管炎患者胃镜下合并病分布情况

胃镜下合并病	例数	个案百分比 (%)
慢性非萎缩性胃炎	105	82.70
糜烂性胃炎	46	36.20
胆汁反流性胃炎	8	6.30
胃溃疡	9	7.10
胃息肉	34	26.80
十二指肠溃疡	5	3.90
十二指肠球炎	23	18.10

续表 2-8 127 例反流性食管炎患者胃镜下合并病分布情况

胃镜下合并病	例数	个案百分比 (%)
贲门息肉	1	0.80
十二指肠球部憩室	2	1.60
慢性萎缩性胃炎	19	15.00
Barret 食管	10	7.90

(五) 临床症状、中医证型分布情况

收集 127 例反流性食管炎患者口咽反流症状、胃脘症状及伴发的全身症状进行叠加统计得出表 2-9。患者均有 1 种或多种临床症状出现,按出现频率最高的前 10 种症状由高到低排列依次为:反酸 69 次、口苦 53 次、腹部胀满 34 次、呃逆 30 次、口淡 29 次、胃脘胀痛 28 次、消谷善饥 26 次、胃脘痞满 25 次、胃脘隐痛 20 次。经拟合优度卡方检验得出论: ($\chi^2=61.4695$, $P=0.000$, $P<0.05$), 差异具有统计学意义,提示反流性食管炎患者常有反酸、口苦、腹部胀满、呃逆等临床症状。

表 2-9 127 例反流性食管炎患者临床症状分布情况

症状	频次	症状	频次
胃脘痞满	25	懒言少语	14
恶心欲呕	1	腹部胀满	34
胃脘胀痛	28	耳鸣	8
胃脘灼痛	13	急躁易怒	7
胃脘隐痛	20	善太喜	8
胃脘刺痛	13	面色苍白	2
胃脘嘈杂	14	头痛	1
纳差	17	腰膝酸软	1
呃逆	30	面色黧黑	7
饥不欲食	2	口臭	1
消谷善饥	26	口淡	29
面色晦暗	5	咽异物感	17
乏力	13	口黏腻	12
胸闷	6	口甜	1
身体困重	11	咽干	14
声音嘶哑	1	口苦	53
胁肋疼痛	1	烧心	18
失眠	5	嗳气	14
头晕	1	反酸	69
面红目赤	1	胸骨后疼痛	13
气短	1	咽部如有痰感	13

127 例反流性食管炎患者中医证型分布如表 2-10 及图 2-2 中所示,肝胃郁热证 34 例 (26.80%), 胆热犯胃证 13 例 (10.20%), 脾虚湿热证 49 例 (38.60%), 气郁痰阻证 8 例 (6.30%), 中虚气逆证 11 例 (8.70%), 瘀血阻络证患者 12 例 (9.40%)。本次研究中反流性食管炎患者的各中医证型例数由多到少依次为:

脾虚湿热证、肝胃郁热证、胆热犯胃证、瘀血阻络证、中虚气逆证、气郁痰阻证。经 χ^2 检验 $\chi^2=18.8118$, $P=0.000$, $P<0.05$ 患者中医证型分布差异具有统计学意义,

反流性食管炎患者最常见为脾虚湿热证、肝胃郁热证。

表 2-10 127 例反流性食管炎患者中医证型分布情况

中医证型	例数	百分比 (%)
肝胃郁热证	34	26.80
胆热犯胃证	13	10.20
脾虚湿热证	49	38.60
气郁痰阻证	8	6.30
中虚气逆证	11	8.70
瘀血阻络证	12	9.40
总计	127	100.00

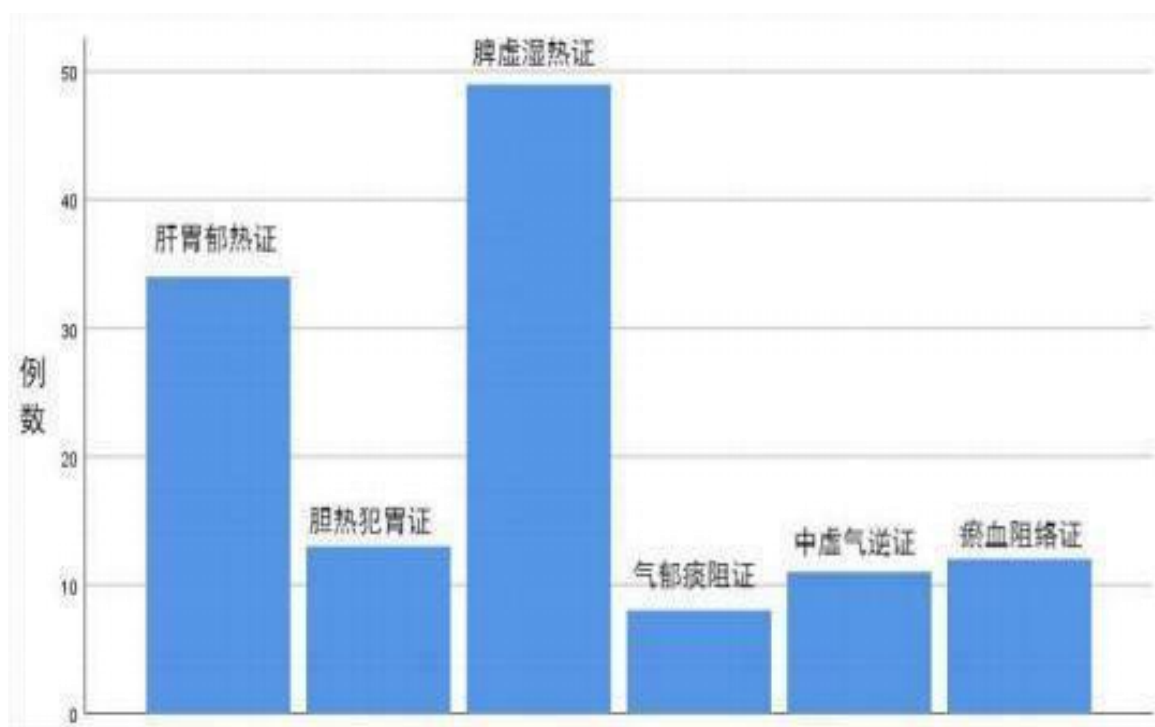


图 2-2 127 例 RE 患者中医证型分布图

(六) 中医证型与年龄、性别关系

本次调查 127 例 RE 患者，年龄最小者 22 岁，最大者 70 岁，平均年龄为 (52.06 ± 12.233) 岁。年龄分成三组：18 岁~44 岁（青年组），45 岁~59 岁（中年组）， ≥ 60 岁（老年组），青年组（18 岁~44 岁）38 人（29.92%），中年组（45 岁~59 岁）45 人（35.43%），老年组（ ≥ 60 岁）44 人（34.64%）。

年龄分组与中医证型之间的关系如表 2-11，青年组肝胃郁热证 9 人、胆热犯胃证 8 人、脾虚湿热证 12 人、气郁痰阻证 2 人、中虚气逆证 5 人、瘀血阻络证 2 人，中年组肝胃郁热证 17 人、胆热犯胃证 2 人、脾虚湿热证 17 人、气郁痰阻证 2 人、中虚气逆证 3 人、瘀血阻络证 4 人，老年组肝胃郁热证 8 人、胆热犯胃证 3 人、脾虚湿热证 20 人、气郁痰阻证 4 人、中虚气逆证 3 人、瘀血阻络证 6 人，运用 Kruskal-

WallisH 秩和检验对下表数据进行检验, 结果显示 RE 患者年龄与中医证型之间差异不具有统计学意义 ($Z=35.72$, $P=0.168$, $P>0.05$), 即 6 种证型均可在不同年龄段发病。

表 2-11 127 例 RE 患者中医证型分布与年龄关系

年龄	中医证型分布						总计
	肝胃郁热证	胆热犯胃证	脾虚湿热证	气郁痰阻证	中虚气逆证	瘀血阻络证	
18-44	9	8	12	2	5	2	38
45-59	17	2	17	2	3	4	45
≥60	8	3	20	4	3	6	44
总计	34	13	49	8	11	12	127

127 例反流性食管炎患者中, 中医证型与性别关系表 2-12, Fisher 确切概率法检验 ($\chi^2=54.84$, $P=0.359$, $P>0.05$), 差异不具有统计学意义, 即各中医证型分布与性别无明显差异, 即男性女性的证型并不固定, 可以发生在任何证型。

表 2-12 中医证型分布与性别关系表

中医证型分布	性别		总计
	男	女	
肝胃郁热证	24	10	34
胆热犯胃证	10	3	13
脾虚湿热证	33	16	49
气郁痰阻证	6	2	8
中虚气逆证	4	7	11
瘀血阻络证	9	3	12
总计	86	41	127

(七) 中医证型与病程、复发关系

127 例反流性食管炎患者病程与中医证型分布关系如表 2-13, 运用 Kruskal-WallisH 秩和检验 ($Z=15.139$, $P=0.013$, $P<0.05$), 结果显示 RE 患者病程与中医证型分布差异具有统计学差异, 进一步两两比较, 脾虚湿热证、肝胃郁热证、胆热犯胃证病程在 1-5 年之间, 提示早期干预对缩短病程有意义。

表 2-13 中医证型分布病程关系

中医证型分布	病程分组[人(%)]				总计
	<1 年	1-3 年	3-5 年	≥5 年	
肝胃郁热证	6 (17.6)	15 (44.1)	10 (29.4)	3 (8.8)	34 (100)
胆热犯胃证	2 (15.4)	7 (53.8)	3 (23.1)	1 (7.7)	13 (100)
脾虚湿热证	1 (2.0)	26 (53.1)	14 (28.6)	8 (16.3)	49 (100)
气郁痰阻证	0 (0.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	4 (50.0)	8 (100)
中虚气逆证	0 (0.0)	4 (36.4)	3 (27.3)	4 (36.4)	11 (100)
瘀血阻络证	0 (0.0)	4 (33.4)	5 (41.7)	3 (25.0)	12 (100)
总计	9 (7.1)	58 (45.7)	37 (29.1)	23 (18.1)	127 (100)

注: 1-3 年: 1 年≤病程<3 年; 3-5 年: 3 年≤病程<5 年

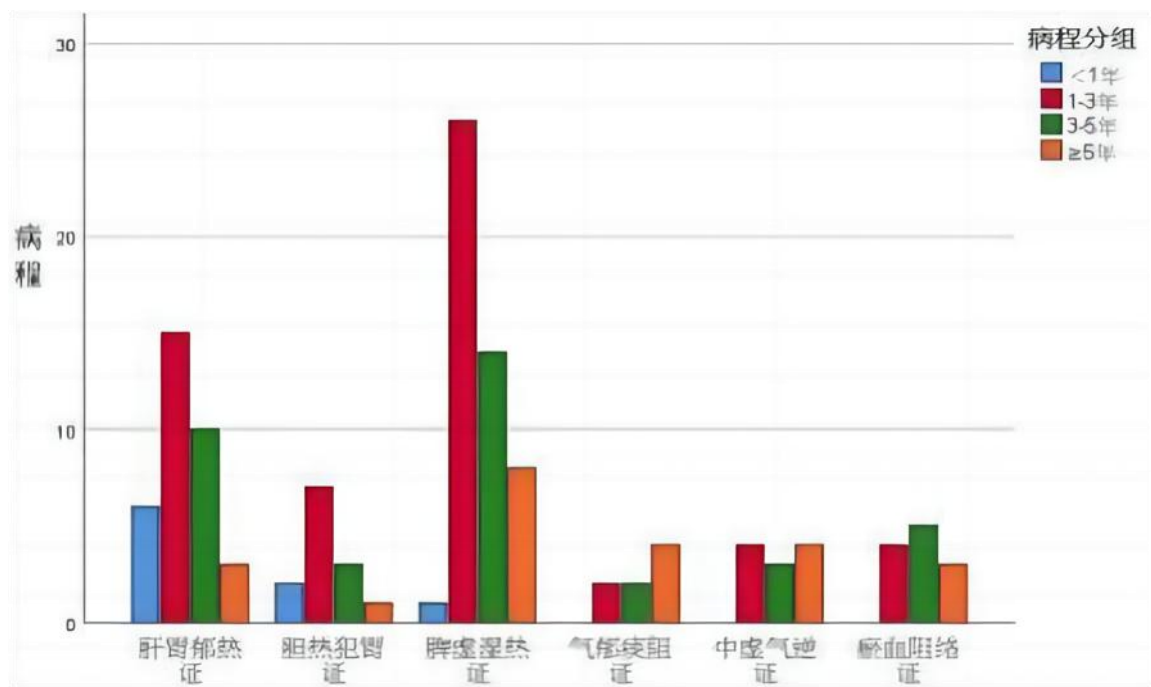


图 2-3 中医证型与病程关系

127 例反流性食管炎患者中医证型与复发关系如表 2-14 表所示，经 Fisher 确切概率法检验，结果提示中医证型分布与是否容易复发相关性差异不具有统计学意义，（ $\chi^2=5.484$ ， $P=0.359$ ， $P>0.05$ ）。

表 2-14 中医证型分布与复发关系

中医证型分布	是否复发		总计
	无	有	
肝胃郁热证	19	15	34
胆热犯胃证	7	6	13
脾虚湿热证	20	29	49
气郁痰阻证	2	6	8
中虚气逆证	2	9	11
瘀血阻络证	4	8	12
总计	54	73	127

（八）中医证型与诱因、饮食偏嗜、居住广州时长关系

本次收集 2023 年 127 例反流性食管炎患者发病诱因，发病诱因分为无发病诱因、劳累、饮食不节（饥饱无常）、情绪失调四类，有单因素发病有多因素叠加发病。中医证型分布与诱因关系分析如表 2-15 所示，饮食不节、情绪失调均是脾虚湿热证、肝胃郁热证的主要诱发因素，胆热犯胃证以情绪失调、劳累为主要诱发因素，气郁痰阻证诱发因素分布均匀，瘀血阻络证发病无明显诱因。Fisher-Freeman-Halton 精确检验进行统计分析（ $\chi^2=113119$ ， $P=0.000$ ， $P<0.05$ ），差异具有统计学意义，提示脾虚湿热证、肝胃郁热证发病多有诱发因素，其主要诱发因素是饮食不节、情绪失调，瘀血阻络证发病可无明显诱因。

表 2-15 中医证型与诱因关系

中医证型	诱因				总计
	无诱因	劳累	饮食不节	情绪失调	
肝胃郁热证	1	2	32	32	67
胆热犯胃证	0	6	2	13	21
脾虚湿热证	1	6	45	44	96
气郁痰阻证	2	1	6	5	14
中虚气逆证	0	9	3	2	14
瘀血阻络证	12	0	0	0	12
总计	16	24	88	96	224

收集 2023 年 127 例反流性食管炎患者饮食习惯因素, 其中 7 例无饮食偏嗜, 其余 120 人有饮食偏嗜, 部分病例饮食多种偏嗜, 将饮食因素与中医证型作关联分析, 得出下列图表结果, Fisher-Freeman-Halton 精确检验进行统计分析 ($X^2=92.180$, $P=0.000$, $P<0.05$), 差异具有统计学意义, 中医证型中肝胃郁热证主要与偏嗜冷饮、偏嗜辛辣、喜饮酒相关, 脾胃虚热证主要与嗜食海鲜、偏嗜冷饮及甜食有主要关系, 胆热犯胃证偏嗜辛辣、喜冷饮、喜浓茶。

表 2-16 中医证型分布与饮食偏嗜关系

饮食偏嗜	中医证型分布					
	肝胃郁热证	胆热犯胃证	脾虚湿热证	气郁痰阻证	中虚气逆证	瘀血阻络证
偏嗜海鲜	4	1	36	0	7	1
偏嗜冷饮	22	6	19	4	1	5
偏嗜辛辣	16	9	9	6	1	4
偏嗜甜食	3	4	12	1	8	1
喜饮浓茶	6	5	5	0	5	2
喜饮酒	11	0	6	0	1	0
无偏嗜	0	1	3	1	0	3

127 例反流性食管炎患者居住广州时长与中医证型关系如图 2-4 及表 2-17 所示, 运用 Kruskal-WallisH 秩和检验差异具有统计学差异 ($Z=13.066$, $P=0.001$, $P<0.05$)。进一步两两比较, 采用 Bonferroni 校正调整后的 P 值, 5-10 年与 ≥ 10 年 ($P=0.003$, $P<0.05$) 差异具有统计学意义, 2-5 年与 ≥ 10 年组 ($P=0.020$, $P<0.05$) 差异具有统计学意义, 居住 ≥ 10 年, 常见气郁痰阻证、脾虚湿热证、瘀血阻络证为主, 2-5 年胆热犯胃证为主。

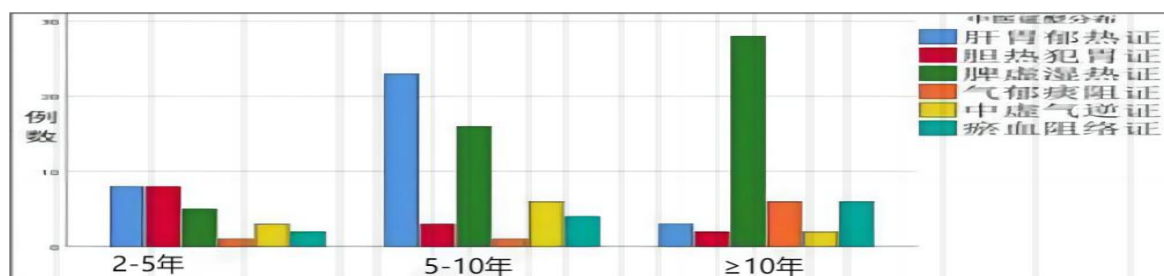


图 2-4 中医证型分布与居住广州时长分布图

表 2-17 中医证型分布与居住广州时长分布情况

中医证型	居住广州时长[人（%）]			总计 [人（%）]
	2-5 年	5-10 年	≥10 年	
肝胃郁热证	8（235）	23（676）	3（88）	34（100）
胆热犯胃证	8（615）	3（231）	2（154）	13（100）
脾虚湿热证	5（102）	16（327）	28（571）	49（100）
气郁痰阻证	1（125）	1（125）	6（75）	8（100）
中虚气逆证	3（273）	6（545）	2（182）	11（100）
瘀血阻络证	2（167）	4（333）	6（500）	12（100）
总计[人（%）]	27（2130）	53（417）	47（370）	127（100）

注：2-5 年组：2 年≤时长<5 年，5-10 组：5 年≤时长<10 年

（九）中医证型与胃镜、胃镜下合并病关系

本次研究 127 例反流性食管炎患者中医证型与胃镜分级关系表 2-18 表所示，A 级 97 例（76.40%）B 级 24 例（18.90%）C 级 4 例（3.10%），D 级 2 例（1.60%）。运用 Kruskal-WallisH 秩和检验对下表数据进行检验分析，（ $Z=0.904$ ， $P=0.824$ ， $P>0.05$ ），差异不具有统计学意义，食管黏膜的损伤程度与中医证型无关。

表 2-18 中医证型分布与 RE 分级分布情况

中医证型分布	RE 分级				总计
	A 级	B 级	C 级	D 级	
肝胃郁热证	26	6	1	1	34
胆热犯胃证	11	1	1	0	13
脾虚湿热证	36	11	1	1	49
气郁痰阻证	7	1	0	0	8
中虚气逆证	8	2	1	0	11
瘀血阻络证	9	3	0	0	12
总计	97	24	4	2	127

127 例反流性食管炎中胃镜下常合并一种或多种其他胃食管疾病其中最常见依次为慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃息肉、十二指肠球炎、慢性萎缩性胃炎、Barret 食管，胆汁反流性胃炎、胃溃疡。

反流性食管炎中医证型与胃镜下合并病如下表，经 Fisher-Freeman-Halton 精确检验（ $X^2=81.662$ ， $P=0.000$ ， $P<0.05$ ），差异具有统计学意义。脾虚湿热证反流性食管炎最容易合慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃息肉、慢性萎缩性胃炎，肝胃郁热证型反流性食管炎容易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃溃疡、十二指肠炎，胆热犯胃证易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃息肉，气郁痰阻证易合并慢性非萎缩性胃炎、胃息肉、十二指肠球炎，瘀血阻络证容易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、十二指肠球炎。中虚气逆证易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃息肉。

表 2-19 中医证型分布与胃镜下合并病

合并病	中医证型					
	肝胃郁 热证	胆热犯 胃证	脾虚湿 热证	气郁痰 阻证	中虚气 逆证	瘀血阻 络证
慢性非萎缩性炎	28	13	37	7	11	9
糜烂性胃炎	13	4	15	1	6	7
胆汁反流性胃炎	2	1	3	1	0	1
胃溃疡病	2	1	3	1	1	1
胃息肉	6	5	14	5	4	0
十二指肠溃疡	1	1	2	0	0	1
十二指肠球炎	8	0	9	3	0	3
Barret 食管	5	0	3	1	0	1
贲门息肉	0	0	1	0	0	0
十二指肠球部室	1	1	0	0	0	0
慢性萎缩性胃炎	3	0	12	1	0	3

第三章 讨 论

本次研究分两部分，第一部分回顾性分析 2021 年 1 月至 2022 年 12 月反流性食管炎病例中医证型分布特点，初步了解本地区中医证型分布特点，试图为第二部分横断面调查提供参考。

第一部分回顾性分析结论为反流性食管炎最常见中医证型为脾虚湿热证及肝胃郁热证，考虑可能与当地气候潮湿炎热及社会压力大有关。

第二部分通过收集 127 例 RE 患者相关信息并进行分析，进一步探究 127 例反流性食管炎患者常见中医证型是否与第一部分回顾性分析结果一致，常见证型否稳定是否有地域代表性。本次调查入组条件之一患者居住广州 2 年以上。广州地处亚热带沿海，气候类型属于亚热带季风气候类型，以日照充足，温暖多雨、四季温差小、夏季长冬季短为特征。因全年雨水丰沛，日照时间长高温使雨水蒸发空气湿度大致该地区气候多处于炎热潮湿。广州地区原住民膳食中喜喝汤粥、喜食海鲜、喜煲凉茶，同时广州是有大量人口迁入的城市，随着人口结构的调整，迁入人口与原住民的饮食喜好互相影响，广州地区居民的饮食习惯也发生了变化。同时广州亦是生活节奏较快、生活压力较大的城市，不良情绪人群比例也有所上升。《黄帝内经》谓：“上工治未病，不治已病，此之谓也”。未病先防，预防疾病的发生，强调摄生，《素问·上古天真论》中指出保健摄生应起居有常、饮食有节，顺应自然规律。未病先防、既病防变，治病求本，中医疾病防治讲究因地制宜。广州气候特点以及人文特点有别于其他地域，可能导致反流性食管炎证型分布、发病因素等有较明显的地域差异，值得我们去探究，为疾病的预防提供更精准的依据。结合上述数据分析结果，现对本次研究中的一般临床资料、反流性食管炎临床特点、中医证型分布规律及相关因素做以下讨论：

第一节 一般资料

一、反流性食管炎发病性别、年龄特点

（一）性别

两部分调查结果均提示反流性食管炎发病存在性别差异，男性发病率比女性高。此次调查结果与其他学者关于反流性食管炎性别与发病率的调查也是相符合的。男性发病较女性高，可能与广州地区生活节奏紧凑，男性的交际喝酒、吸烟较女性多使食管下括约肌、胃食管交界区压力下降，使反流性食管炎发生的机率增加，同时社会压力更大容易有不良情绪使体内胃肠神经递质的改变诱发反流性食管炎的发生。此结果也提示男性更应该注意加强反流性食管炎的预防。

（二）年龄

回顾性分析部分年龄最小 20 岁，最大 70 岁，平均年龄为（51.03±12.7168）岁，年龄分成三组：18 岁~44 岁（青年组），45 岁~59 岁（中年组），≥60 岁（老年组），青年组 52 例（30.40%），中年组 64 例（37.40%），老年组 55 例（32.20%）。横断面调查部分年龄最小 22 岁，最大 70 岁，平均年龄为（52.06±12.233）岁，青年组 38 人（30.40%），中年组 45 人（37.40%），老年组 44 人（32.20%）。各年龄组的发病率差异不具有统计意义，但许凤英^[32]研究的反流性食管炎青年组发病率高，不排除与地域差异及本次调查样本量小有关。

二、反流性食管炎病程规律及复发情况

（一）病程

127 例反流性食管炎患者中，病程<1 年 9 人（7.10%），病程 1-3 年 58 人（45.70%），病程 3-5 年 37 人（29.10%），病程超过 5 年 23 人例（18.10%）。病程超过 1 年的占 92.90%，差异具有统计学意义说明反流性食管炎病程迁延难愈，目前仍未有极佳的治愈方法，究其原因与目前我们对该疾病的认识尚未完全清晰，仍需要我们去探索挖掘更多的预防和治疗方法。

（二）复发

127 例 RE 患者中，首次发病 54 例，复发 73 例，首发占比 42.50%，复发占比 57.50%，（ $P>0.05$ ）差异不具有统计学意义，说明目前疾病发病率高，复发率也高，西医治疗手段有限，病情反复发作，患者寻求中医治疗，对中医治疗寄予厚望。

三、反流性食管炎发病诱因、饮食结构分析

（一）诱因

127 例 RE 患者中无诱因发病 16 人，111 人为单因素或多因素叠加发病，劳累过度 24 次（10.70%），饮食不节发病 88 次（39.30%），因情绪失调发病 96 次（42.90%），差异具有统计学意义。《临证备要·吞酸》：“胃中泛酸，嘈杂有烧灼感，多因于肝气犯胃”，《医学正传》认为“肝热则口酸”。广州地区生活节奏紧凑、生活压力大，思虑忧郁情志失畅致气机郁滞运行不畅，肝失疏泄，肝气横逆犯胃，胃升降失和而致病，此研究结果提示减少疾病的发生和复发需要注意指导患者做好不良情绪疏导、注意饮食有度。

（二）饮食偏嗜

《医方论·卷四》中云：“人非脾胃无以养生，饮食不节病即随之，多食辛辣则火生，多食生冷则寒生，多食浓厚则痰湿俱生，于是为积聚、为胀满、为泄痢，种种俱见。”《严氏济生方·宿食门》曰“善摄生者，谨于和调，一饮一食……若禀受怯弱，饥饱失时，或过餐五味，鱼腥乳酪，强食生冷果菜，停蓄胃脘，遂成宿滞，轻则吞酸呕恶，胸满噎噫，或泄或痢。”饮食不节，肆食生冷辛辣，肥甘厚味，损伤脾胃，胃脾胃虚弱或脾虚湿滞郁而化热，脾气不升，胃气不降，升降失调，则胃气上逆。

127 例 RE 患者中无饮食偏嗜 8 人，有饮食偏嗜 119 人。统计获得饮食因素共 229 个，去除无饮食偏嗜 8 个（3.50%），对有饮食偏嗜进行多因素叠加统计高到低依次为：偏嗜冷饮（24.60%）、偏嗜海鲜（21.40%）、偏嗜辛辣（19.70%）、偏嗜甜食（12.70%）、喜饮浓茶（10.00%）、喜饮酒（7.90%），（ $P<0.05$ ）差异具有统计学意义，提示发病多存在饮食偏嗜，且饮食偏嗜中冷饮、海鲜为较高占比。发病多存在饮食偏嗜，这与众多学者的研究是相一致的，但偏嗜结构有所不同，可能与地域有关。袁玲芝^[43]对胃食管反流病患者不良生活习惯进行调查得出结果偏好辛辣食物>偏好高脂食物>偏好酸性食物>偏好甜食>偏好硬食>偏好浓茶>偏好咖啡。许凤英^[44]研究的反流性食管炎患者的饮酒偏嗜结果为习惯饮酒>喜食油腻>喜食海鲜>喜食甜食>喜食辛辣>喜饮浓茶。

本次研究结果是偏嗜冷饮>偏嗜海鲜>偏嗜辛辣>偏嗜甜食>喜饮浓茶>喜饮酒。可能与本地区地处沿海海鲜丰富夏季时间长天气炎热有关，本地区居民因海鲜丰富就地取材故偏爱进食海鲜，天气炎热故喜爱偏冷饮解暑，同时本市为人口迁入城市，饮食结构有从清淡饮食转变为偏嗜辛辣的趋势，除去偏嗜海鲜、冷饮，偏嗜辛辣可能成为本地区新的常见致病因素。

从祖国医学的认识到现代医学研究均提示反流性食管炎发病多有外因，情绪失调、饮食不节是反流性食管炎发病的常见诱发因素。因各地域有差异，因地制宜针对本地区的常见致病因素做出更有针对性的健康教育并纠正其不良生活习惯，才能更好地预防疾病的发生、减少疾病的复发，这也是本研究的目的之一。

四、反流性食管炎临床症状、胃镜分级、胃镜下合并病及中医证型分布

（一）反流性食管炎胃镜分级、胃镜下合并病分析

胃镜分级 A 级 97 例（76.40%）B 级 24 例（18.90%）C 级 4 例（3.10%），D 级 2 例（1.60%），（ $P<0.05$ ）差异具有统计学意义。胃镜下合并其他胃食管疾病按个案率由高到低排名依次为慢性非萎缩性胃炎 105 例（82.70%）、糜烂性胃炎 46 例（36.20%）、胃息肉 34 例（26.80%）、十二指肠球炎 23 例（18.10%）、慢性萎缩性胃炎 19 例（15.00%）、Barret 食管 10 例（7.90%）、胃溃疡 9 例（7.10%）、胆汁反流性胃炎 8 例（6.30%），部分病例合并多种其他胃部疾病，（ $P<0.05$ ）差异具有统计学意义。合并病的高发多发提示做好反流性食管炎的预防的必要性。减少反流性食管炎的发生将更大地减少患者的疾苦、减轻社会医疗负担。

（二）反流性食管炎临床症状、中医证型分布分析

127 例 RE 患者口咽反流症状、胃脘症状及全身症状进行叠加统计，患者均有 1 种或多种临床症状出现，按出现频率最高的前 10 种症状，由高到低排列依次为：反酸 69 次、口苦 53 次、腹部胀满 34 次、呃逆 30 次、口淡 29 次、胃脘胀痛 28 次、消谷善饥 26 次、胃脘痞满 25 次、胃脘隐痛 20 次，（ $P<0.05$ ）差异具有统计学意义。

《四明心法·吞酸》亦云：“凡为吞酸尽属肝木，曲直作酸也”《诸病源候

论·呕哕病诸候》云：“噫醋者，由上焦有停痰，脾胃有宿冷，故不能消谷，谷不消则胀满而气逆，所以好噫而吞酸，气息醋臭。”临床症状研究结果反酸、口苦高频率出现，与古代医家对反酸的深刻认识是相符合的，本次研究结果佐证了祖国医学对反流性食管炎的认识。

中医证型分布由多到少依次为：脾虚湿热证 49 例（38.60%）、肝胃郁热证 34 例（26.80%）、胆热犯胃证 13 例（10.20%）、瘀血阻络证 12 例（9.40%）、中虚气逆证 11 例（8.70%）、气郁痰阻证 8 例（6.30%），（ $P<0.05$ ）差异具有统计学意义，反流性食管炎患者最常见为脾虚湿热证、肝胃郁热证。

岭南温病学家陈任枚在《温病学讲义》指出：“东南濒海之区，土地低洼，雨露时降，至春夏二令，赤帝司权，热力蒸动水湿，其潮气上腾，则空气中常含有多量之水蒸气。人在其中，吸入为病，即成湿热，湿温，”本次研究对象所处的地理环境与气候背景无不与上相符，湿热证是本地区的“天然”证候。《素问·至真要大论》说：“诸湿肿满，皆属于脾。”清初著名岭南医家陈复正云：“凡脾虚多病湿，内因酒面停滞，嗜瓜果，喜生冷，烧炙甘肥，以致湿热壅溢而为病者，此内因也”。因本地区气候潮湿炎热，居民喜嗜冷饮消暑解渴，喜饮清热降火凉茶及汤水，日久伤脾，脾失健运，湿从内生。外湿引动内湿，脾气不升，胃气不降，升降失调，则胃气上逆，故而发病，同时本地区生活节奏快，不良情绪失疏，致肝气郁结且生冷、辛辣饮食致气机逆乱，肝气横逆犯胃，胃失和降，上冲侵犯食管而发本病，本次研究发现脾虚湿热证、肝胃郁热证多见，无不与以上因素有关。

第二节 中医证型与相关因素

一、中医证型分布与性别、年龄关系

本次调查结果显示反流性食管炎发病与性别相关性差异有统计学意义，但中医证型分布与性别相关性差异不具有统计学意义，不排除有与样本量小、病源来源单一有关。反流性食管炎中医证型分布与年龄相关性差异无统计学意义，与临床常见及部分文献结果有差异，6 种证型均可在不同年龄段发病，不排除与地域及社会因素有关，随着社会的进步发展，饮食结构改变，生活、工作压力增大，既往以老年组为主的瘀血阻络证也可能发生在中青年组，以青年组为主的胆热犯胃证也可在中、老年组成为高发。因饮食不当、情志失调，损伤肝脾，气机失调，气滞血瘀胶结，侵袭胃络而发病。生活工作压力大，日久容易情志失调，且饮食不规律嗜食辛辣，引起肝疏泄失常，气机不畅，郁而化热横犯于胃。

二、中医证型分布与病程、复发关系

127 例 RE 患者病程与中医证型分布之间的关系差异具有统计学意义，脾虚湿热证、肝胃郁热证、胆热犯胃证病程在 1-5 年之间，提示早期干预对缩短病程有意义。

中医证型与复发关系差异不具有统计学意义，即任何证型其复发率都高，提示任何证型均需针对不同证型诱发因素做好干预才能有效减少疾病的反复发作。

本病病理因素虚实皆有，虚责之脾气虚、胃阴虚，实责之痰、湿、热、气、郁、瘀。本病病机特点热、郁、逆，本病初起期以实热证为主，后为虚实夹杂。早期肝气不舒、胆气不利，肝胆失于疏泄、脾失健运、胃失和降、胃气上逆上犯于食管。久病则虚，正气虚衰，脾胃虚弱或脾虚湿滞郁而化热，脾气不升，胃气不降，升降失调，则胃气上逆。气行则血行，气机不畅，气滞则血瘀，久病入络，故见瘀血阻络之证，病情继续发展，则中气虚衰，则见中虚气逆证。各证型病程的长短符合本病先虚后实，虚实夹杂的病机。

广州地区生活节奏紧凑、生活压力大，思虑忧郁情志失畅致气机郁滞运行不畅，肝失疏泄，加之天气潮湿炎热、地处沿海嗜食海鲜、冷饮、辛辣，居民体质多有湿热，故病程早期除可见胆热犯胃证、肝胃郁热证，早期亦可见脾虚湿热证。脾阳不振水湿内停，湿性粘滞，致病情反复迁延。

三、中医证型与诱因、饮食及居住广州时长关系

本次研究发现 RE 的不同中医证型其发病诱因存在差异。脾虚湿热证、肝胃郁热证的主要诱发因素是饮食不节、情绪失调。

在饮食结构上 RE 不同中医证型其饮食偏嗜存在差异。肝胃郁热证主要与偏嗜冷饮、偏嗜辛辣、喜饮酒相关，脾胃虚热证主要与嗜食海鲜、偏嗜冷饮及甜食有主要关系，胆热犯胃证偏嗜辛辣、喜冷饮、喜浓茶，气郁痰阻证、瘀血阻络证未发现与饮食偏嗜有关联。

居住广州的时长也影响 RE 的中医证型。居住 ≥ 10 年，常见气郁痰阻证、脾虚湿热证、瘀血阻络证为主，2-5 年胆热犯胃证为主。

国医大师邓铁涛曾总结说：“岭南这种炎热潮湿的气候，经千百年来逐渐形成了岭南人的特有体质，即脾气虚弱兼有湿热[45]。”广州地处亚热带沿海，夏季长冬季短为特征。因全年雨水丰沛，日照时间长高温使雨水蒸发使空气湿度大致该地区气候多处于炎热潮湿，外感六邪之一成为当地常见致病因素。同气相感，脾性属湿，外感湿邪日远归脾影响脾运化之功，脾胃之气受损湿从内生。《黄帝内经》云：“人之汗，以天地之雨名之。盖汗之为物，以阳气为运用，以阴精为材料”。《素问·阴阳别论》说“阴加于阳谓之汗”当地居民常多汗出，久必伤阳，脾阳受损，脾阳不振，脾失健运水，湿从内生，复感外湿之邪，外湿困脾必致水湿内停郁而化热致脾虚内热。久居广州后饮食同化肥甘厚腻，不忌辛辣生冷、喜饮清热降火凉茶，日久伤脾容易导脾气不运，致湿邪内留，古有“肥者令人内热”之说，造成了脾虚内热。广州地区生活节奏紧凑、生活压力大，易致思虑忧郁情志失畅，肝失疏泄。气候、社会环境、饮食偏嗜错综交杂导致了地域特色的中医证型分布。

为减少疾病的发生，要及时指导患者疏导不良情绪、保持愉悦的心情及良好的

心理状态，防止疾病的进一步发展，饮食方面倡导传承广州清淡的饮食文化，忌肥甘厚腻，减少辛辣刺激，海产品食之有度，减少生冷冰凉之物，逐渐改变无度凉茶的饮食习惯，同时应该戒烟、戒酒，保持健康的生活方式，方能减少疾病的发生，促进疾病的康复。

四、中医证型分布与胃镜分级及胃镜下合并病关系

中医证型分布与胃镜分级相关性差异不具有统计学意义，但反流性食管炎中医证型分布与胃镜下合并病相关性差异具有统计学意义。脾虚湿热证 RE 最容易合慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃息肉、慢性萎缩性胃炎，肝胃郁热证 RE 容易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎胃溃疡、十二指肠炎，胆热犯胃证、气郁痰阻证与瘀血阻络证相似容易合并慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胃息肉。

《素问·玉机真脏论》说：“五脏相通，移皆有次。”《金匱要略》云“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”无论是中医学的认识还是现代医学的认识，都用事实充分证实了人体是一个有机的整体，五脏相互资生、相互制约，维持正常生命活动；五脏病邪相互影响、互相传变。因此，我们必须有整体思想，治病求本，以平为期，知常达变，未病先防、既病防变的防治法则始终贯穿疾病的过程。

结 语

一、结论

1. 调查结果提示反流性食管炎发病中男性多于女性，男性更应注意 RE 的预防。RE 的发病与年龄相关性差异不具有统计学意义，疾病的防治要及早，该部分调查结果与部分文献有差异，不排除与地域差异及样本量小有关。

2. 中医证型调查方面，调查结果提示脾虚湿热证、肝胃郁热证为最常见证型，此结果提示脾虚湿热证、肝胃郁热证可能为该地区常见类型，可为以后大样本调查提供借鉴。

3. 调查结果提示 RE 的发病与不良情绪、饮食不节（饥饱无度）、饮食结构有相关性，为减少疾病发生可根据本地区诱发因素、饮食偏嗜做好养护和调摄指导。

4. RE 中医证型分布与胃镜分级无相关性，而与胃镜下合并病有相关性。脾虚湿热证、肝胃郁热证 RE 均最容易合慢性非萎缩性胃炎、糜烂性胃炎，证型干预有可能减少合并病的发生。传统医学与现代医学相结合研究、互为补充为 RE 防治提供直观依据。

5. RE 中医证型分布与性别、年龄相关性差异不具有统计学意义，不排除与地域差异及样本量小有关。中医证型与病程长短有相关性。中医证型分布与诱因、饮食偏嗜、居住广州时长有相关性。本次研究发现最常见中医证型脾虚湿热证、肝胃郁热证均与饮食不节，偏嗜冷饮、辛辣、海鲜，长期居住广州有密切相关，研究结果提示本地区居民常见证型脾虚湿热证，其致病因素多与本地气候潮湿、长期嗜食生冷、海鲜损伤脾胃有关，外湿引动内湿，久湿化热而致病，倡导居民饮食上可多食用清宣化湿之品祛外湿，健脾渗湿之品化内湿。肝胃郁热证多因广州地区生活节奏紧凑、生活压力大，易致思虑忧郁情志失畅，肝失疏泄，加之与气候、饮食偏嗜错综交杂而致，平素应做好指导不良情绪疏导及饮食调护。

疾病发生、病程演变、疾病的复发均与平素摄生养护有关，因地制宜了解当地常见致病因素，精准干预方能更好减少疾病的发生，缩短疾病的病程，减少患者痛苦，减少国家医疗负担。

二、不足与展望

但本研究仍存在不足之处：本研究由于时间限制及疫情影响，收集的病例数相对少，病例来源单一代表性不足，中医证型确立具有一定主观性。期望在今后能进行更大样本、多中心的研究，中医证型确定运用更为客观的评价标尺，以便得出更全面、更客观的流行病学结果，能更好的运用于临床指导。

参考文献

- [1] 潘雯,陈小红,刘超,等. 老年难治性反流性食管炎的胃镜分级及其影响因素 [J]. 中国老年学杂志, 2020, 40 (10): 2092-2095.
- [2] 汪忠镐, 吴继敏, 胡志伟, 等. 中国胃食管反流病多学科诊疗共识 [J]. 中华胃食管反流病电子杂志, 2020, 7 (01): 1-28.
- [3] 张声生, 朱生樑, 王宏伟, 周秉舵. 胃食管反流病中医诊疗专家共识意见. (2017) [J]. 中国中西医结合消化杂志, 2017, 25 (05): 321-326
- [4] 张北华, 周秉舵, 唐旭东. 胃食管反流病中医诊疗专家共识 (2023) [J]. 中医杂志, 2023, 64(18): 1935-1944. DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2023.18.019.
- [5] 汪忠镐, 吴继敏, 胡志伟, 等. 中国胃食管反流病多学科诊疗共识 [J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2019, 11(09): 30-56.
- [6] 熊理守, 陈湖, 陈惠新, 等. 广东省社区人群胃食管反流病流行病学研究 [J]. 中华消化杂志, 2006, 26 (4): 239-242
- [7] 周金池, 赵曙光, 王新, 等. 中国部分地区基于社区人群胃食管反流患病率 Meta 分析 [J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2020, 29 (9): 1012-1020. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5709.2020.09.012
- [8] H L E , Raguprakash R , Yuhong Y , et al. Global prevalence of, and risk factors for, gastro-oesophageal reflux symptoms: a meta-analysis. [J]. Gut, 2018, 67 (3): 430-440.
- [9] Peery AF , Dellon ES , Lund J , et al. Burden of gastrointestinal disease in the United States: 2012 update [J]. Gastroenterology , 2012, 143 (5): 1179-1187. DOI: 10.1053/j.
- [10] Pohl H , Wrobel K , Bojarski C , et al. Risk factors in the development of esophageal adenocarcinoma [J]. Am J Gastroenterol , 2013, 108 (2): 2002-2007. DOI: 10.1038/ajg.
- [11] 唐冰. 反流性食管炎中医证型、体质及与胃镜分级相关性研究 [D]. 广州中医药大学. 2015.
- [12] 朱生樑. 胃食管反流病基础与中西医临床 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2015: 24-25.
- [13] 2020 年中国胃食管反流病专家共识 [J]. 中华医学会消化病学分会. 中华消化杂志, 2020, 40 (10): 649-663. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367.20200918.00558
- [14] 应海峰, 朱生樑. 胃食管反流病中医病名的探讨 [C]. 中华中医药学会第二十一届全国脾胃病学术交流会论文汇编, 2009.
- [15] 李开杨, 蔺晓源, 赵琦等基于名医经验的反流性食管炎中医病名、病因病机、证候分型研究 [J]. 山西中医, 2022, 38. (10): 51-54. DOI: 10.20002/j.issn.1000-7156.2022.10.022.
- [16] 杨旭, 潘飞辰, 李平, 等. 沈洪治疗胃食管反流病临证经验 [J]. 河北中医, 2015, 37 (5): 653-655.
- [17] 陶琳, 张声生. 调肝理脾理论运用胃食管反流病现状和思考 [J]. 世界中医药, 2015, 10 (5): 671-675.
- [18] 李敬华, 胡建华, 张丽颖, 等. 唐旭东通降法治疗胃食管反流病经验 [J]. 中医杂志, 2012, 53 (20): 1779-1780
- [19] 胃食管反流病中医诊疗专家共识意见 (2017) [J]. 中华中医药学会脾胃病分会中国中西医结合消化杂志.
- [20] 魏桐. 反流性食管炎的中医证候分布规律及相关因素研究 [D]. 天津中医药大学, 2021. DOI:

10.27368/d.cnki.gtzyy.202.1.0004.1.1

- [21] 陶琳, 沈晨, 朱艳琴, 侯亚男.胃食管反流病不同中医证型的食管动力特点[J].中国中西医结合消化杂志, 2017, 25. (02): 81-84.
- [22] 郑榕, 杨正宁, 骆云丰, 黄铭涵.国医大师杨春波辨治反流性食管炎的经验[J].时珍国医国药, 2021, 32. (02): 473-475.
- [23] 朱恩超.反流性食管炎的胃镜分级与中医证型的调查研究[D].云南中医学院, 20.17.
- [24] 陈可冀.实用中西医结合内科学[M]北京: 北京医科大学协和医科大学联合出版社, 1998: 605-606.
- [25] 王万卷, 丁霞, 文智英, 等反流性食管炎的中医证候分类研究[J].中华中医药杂志, 2011, 26. (07): 1515-1518.
- [26] 师宁, 丁霞, 杭海燕等.反流性食管炎中医证候分布特点的研究[J].中华中医药杂志, 2012, 27. (04): 1174-1176.
- [27] 曹雨佳.针灸治疗反流性食管炎 90 例疗效观察[J].亚太传统医药, 2016, 12. (20): 93-94.
- [28] 宋博媛, 高望.基于数据挖掘探究反流性食管炎的证型及用药规律[J].云南中医中药杂志, 2024, 45. (02): 56-63.DOI: 10.16254/j.cnki.53-1120/r.2024.02.007.
- [29] 李良玉, 周兰利.中医综合疗法治疗反流性食管炎疗效观察[J].光明中医, 2017, 32. (12): 1693-1695.
- [30] 林益群.黄连温胆汤加味治疗反流性食管炎 32 例[J].新中医, 2008. (07): 77DOI: 10.13457/j.cnki.jncm.2008.07.037.
- [31] 许凤莲.一贯煎加味治疗反流性食管炎 60 例[J].中医研究, 2013, 26. (03): 40-42.
- [32] 李榕萍, 曹雯.中药辨证治疗反流性食管炎 70 例疗效观察[J].海峡药学, 2016, 28. (3): 130-131.
- [33] 付丽英.舒肝和胃汤治疗反流性食管炎 80 例临床分析[J].中国继续医学教育, 2016, 8. (2): 186-187.
- [34] 何恽晔, 蔡浩获, 洪粉丹.疏肝和胃汤治疗反流性食管炎随机平行对照研究[J].实用中医内科杂志, 2014, 29. (4): 48-50.
- [35] 周晓明.加味连苏饮方治疗反流性食管炎(湿热蕴中证)临床观察[J].中国中医急症, 2015, 24. (12): 2239-2241.
- [36] 王振民., 杨威涛, 李洁等.三行汤治疗反流性食管炎 79 例临床观察[J].河北中医, 2012, 34. (9): 1316-1317.
- [37] 陶紫晶, 独思静, 张格知, 曹增, 魏玮.基于 CiteSpace 可视化分析中医药治疗胃食管反流病的研究热点与前沿[J].中医药导报, 2022, 28. (03): 97-102.DOI: 10.13862/j.cn43-1446/r.2022.03.020.
- [38] 朱峰, 李杨, 张鹏, 方正.益气除痞汤治疗反流性食管炎的效果及对胃肠动力、白细胞介素-17、白细胞介素-23 的变化影响[J].中华中医药学刊, 2022, 40. (08): 193-196.DOI: 10.13193/j..issn.1673-7717.2022.08.046.
- [39] 徐辉.清.胃.降逆方治疗肝胃郁热型反流性食管炎的临床疗效观察及对血清 MTL 的影响[D].安徽中医药大学, 2018.
- [40] 徐庆, 周荣, 丁顺斌, 谢桂琼, 何娅芝.栀子甘草豉汤加味治疗反流性食管炎疗效及对食管.pH.值、动力学及血清 CGRP、IL-17..的影响[J].四川中医, 2022, 40. (10): 95-98.
- [41] 宋凌.反流性食管炎的危险因素及生活方式干预[J].中外医疗, 2009, 28. (9): 48-49

- [42] 袁玲芝, 唐丹, 彭进等. 针对胃食管反流病患者不良生活习惯的调查研究[J]. 中南大学学报. (医学版), 2017, 42. (05): 558-564.
- [43] 许凤英. 泉州地区反流性食管炎中医证型分布规律及相关因素研究[D]. 福建中医药大学, 2022. DOI: 10.2702.1/d.cnki.gfjzc.202.1.000343.
- [44] 王云飞, 吴焕林. 邓铁涛教授与岭南医学[J]. 新中医, 2007. (06): 92-93

附 录

附录 1

参照胃食管反流病中医诊疗专家共识意见（2017））

反流性食管炎的中医证型诊断标准：

（1）肝胃郁热证

主症：①烧心；②反酸。

次症：①胸骨后灼痛 ②胃脘灼痛 ③脘腹胀满 ④暖气或反食 ⑤易怒 ⑥易饥

舌脉：①舌红，苔黄 ②脉弦

（2）胆热犯胃证

主症：①口苦咽干 ②烧心

次症：①胁肋胀痛 ②胸背痛 ③反酸 ④暖气或反食 ⑤心烦失眠 ⑥易饥

舌脉：①舌红，苔黄腻 ②脉弦滑

（3）脾虚湿热证

主症：①餐后反酸 ②饱胀

次症：①胃脘灼痛 ②胸闷不舒 ③不欲饮食 ④身倦乏力 ⑤大便溏滞

舌脉：①舌淡或红，苔薄黄腻 ②脉细滑数

（4）瘀血阻络证

主症：①胸骨后灼痛或刺痛

次症：①后背痛 ②呕血或黑便 ③烧心 ④反酸 ⑤暖气或反食 ⑥胃脘刺痛

舌脉：①舌质紫暗或有瘀斑 ②脉涩

（5）中虚气逆证

主症：①反酸或泛吐清水 ②暖气或反流

次症：①胃脘隐痛 ②胃痞胀满 ③食欲不振 ④神疲乏力 ⑤大便溏薄

舌脉：①舌淡，苔薄 ②脉细弱。

（6）气郁痰阻证

主症：①咽喉不适如有痰梗 ②胸膈不适。

次症：①暖气或反流 ②吞咽困难 ③声音嘶哑 ④半夜呛咳

舌脉：①舌苔白腻 ②脉弦滑

证型确定：具备以上主症 2 项，加次症 2 项，参考舌脉，即可诊断证型，无症状者以舌脉象+胃纳情况+大便情况诊断证型。

附录 2

患者临床资料记表

1.患者姓名: _____ 性别: _____ 男口 女口 年龄: _____ 岁

在广州居住年数: _____ 联系电话: _____

2.病程: <1 年口 1-3 年口 3-5 年口 5 年口

3.BMI: 偏瘦<18.5 口 正常范围 18.5-24.0 口

超重≥24.0 口 肥胖≥28.0 口

4.诱发因素: 情绪失调口 饮食不节(饥饱无常)口 劳累口 无明显诱因口

5.饮食偏嗜: 无偏嗜口 偏嗜甜食口 偏嗜辛辣口

偏嗜海鲜口 偏嗜冷饮口 喜饮浓茶口

喜饮酒口 其他

6.是否为首次发病: 是口 否口

7.RE 分级:

正常: 食管黏膜无破溃口

A.级: 食管黏膜有一个或一个以上黏膜破损, 长径≤5 mm (局限于 1 个黏膜皱襞内) 口

B.级: 一个或一个以上黏膜破损, 长径>5mm (局限于 1 个黏膜皱襞内), 且病变没有融合。 口

C.级: 黏膜破损有融合, 但<75%的食管周径 口

D.级: 黏膜破损相互融合范围累积至少≥ 75%的食管周径口

8.胃镜下合并症

慢性萎缩性胃炎口

糜烂性胃炎口

胆汁反流性胃炎口

胃溃疡口

胃息肉口

十二指肠溃疡口

十二指肠球炎口

十二指肠息肉口

食管裂孔疝口

Barret 食管口

贲门炎口

贲门息肉口

附录 3

编号: _____

患者姓名: _____ 性别: 男 ☐ 女 ☐ 年龄: _____ 岁

主诉			
症状	主症		
	次症		
舌脉			
辨证分型	肝胃郁热证 ☐ 胆热犯胃证 ☐ 脾虚湿热证 ☐ 瘀血阻络证 ☐ 中虚气逆证 ☐ 气郁痰阻证 ☐		

临床症状

有下列症状即打 ☒

反流 症状	烧心 () 反酸 () 反食 () 胸骨后疼痛 ()
口咽 症状	吞咽困难 () 口苦 () 口臭 () 口渴 () 口甜 () 口淡 () 口中粘腻 () 咽痛 () 咽干 () 咽异物感 () 声音嘶哑 () 咽喉不适如有痰梗 ()

胃脘症状	胃脘灼痛 () 胃脘胀痛 () 胃脘刺 () 胃脘隐痛 () 胃脘痞满 () 饥不欲食 () 胃脘嘈杂 () 纳差 () 恶心欲呕 () 呃逆 () 消谷善饥 () 噯气 ()
全身症状	面红目赤 () 面色苍白 () 面色苍黄 () 面色无华 () 面色晦暗 () 面色黧黑 () 胁肋疼痛 () 胁肋胀满 () 身体困重 () 声音嘶哑 () 腰膝酸软 () 腹部胀满 () 形体消瘦 () 畏寒肢冷 () 急躁易怒 () 善太喜口 () 乏力 () 懒言 () 头晕 () 耳鸣 () 头痛 () 气短 () 心悸 () 胸闷 () 失眠 ()
二便症状	排便正常 () 黑便 () 大便黏腻 () 便后不尽感 () 里急后重 () 排便无力 () 大便稀溏 () 大便干燥 () 大便每日一行 () 大便 2 日一行 () 大便数日一行 () 大便每日 2-3 次 () 大便每日 4 次以上 () 小使正常 () 小便清长 () 小便短赤 ()
舌色、舌质	淡红 () 淡白 () 红 () 暗红 () 绛 () 胖大 () 瘦薄 () 裂纹 () 齿痕 () 舌下静脉曲张 () 瘀点瘀斑 ()
舌苔	白 () 黄 () 薄 () 厚 () 腻 () 干 () 水滑 () 剥苔 () 少或无 ()
脉象	滑 () 数 () 弦 () 细 () 沉 () 紧 () 迟 () 弱 () 濡 () 浮 ()

附录 4

胃镜检查前告知书

- 1、准备行胃镜检查患者检查前一日应清淡饮食，检查前一天 22:00 点后禁食禁水，保持空腹。
- 2、如有活动性假牙者请取出，建议穿宽松衣服。
- 3、检查将由专业人员实施，检查前若有不适应及时告知医护人员，医护将重新评估是否继续行胃镜检查，如不能如期进行胃镜检查，择日行胃镜检查。
- 4、如有长期服用阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片等抗血小板或华法林、达比加群等抗凝药需如实告知医生，停药 1 周后方行胃镜检查，防止消化道大出血发生。

附录 5

方案名称：反流性食管炎中医证型分布特点及相关因素研究

知情同意书

请您仔细阅读以下内容

您将被邀请参加一项临床研究。本知情同意书提供给您一些信息以帮助您决定是否参加此项临床研究。请您仔细阅读，如有任何疑问可以随时向负责该项研究的研究者提出，研究人员将为您详细解答。您可以根据自己的情况作出决定，您将有充分的时间进行考虑。

一、研究风险与不适

您参加本研究完全是自愿的。我们希望您能积极配合，对我们所陈述的病情准确、真实，毫无保留和隐瞒，如果您有何隐情不愿将病情如实告知医生，请您与医生讲明，可考虑退出本研究，您的退出将不会影响您与医生的关系，医生将根据您所告知的病情和患者至上的原则对您进行合理的治疗。您的医疗记录将完整的保存在医院。任何有关本项目研究结果的公开报告将不会披露您的个人身份。填写的所有资料都将为您保密，感谢您的大支持。

二、参加研究受益

通过对您的相关资料收集，为您的治疗提供必要的建议，为疾病的研究提供有益的信息。

三、相关费用

本课题的研究费用由课题经费中支出。治疗过程中您需要支付相应的门诊或住院治疗费用，但不会额外增加受试者临床常规诊疗以外的费用。另外，参加本研究您不会得到任何经济补偿。

四、受试者职责

作为研究受试者，您有以下职责：提供有关自身病史和当前身体状况的真实情况；告诉研究医生自己在本次研究期间所出现的任何不适；告诉研究医生自己在最近是否曾参与其他研究，或目前正参与其他研究。

五、自愿参加

您可以选择不参加本项研究，或者在任何时候通知研究者要求退出研究，您的数据将不纳入研究结果，您的任何医疗待遇与权益不会因此而受到影响。

如果您需要其它治疗，或者您没有遵守研究计划，或者发生了与研究相关的损伤或者有任何其它原因，研究医师可以终止您继续参与本项研究。

六、隐私保密

如果您决定参加本项研究，您参加试验及在试验中的个人资料均属保密。您将以研究编号数字而非您的姓名加以标识。可以识别您身份的信息将不会透露给研究小组以外的成员，除非获得您的许可。所有的研究成员和研究申办方都被要求对您的身份保密。您的档案将保存在有锁的档案柜中，仅供研究人员查阅。为确保研究按照规定进行，必要时，政府管理部门或伦理审查委员会的成员按规定可以在研究单位查阅您的个人资料。这项研究结果发表时，将不会披露您个人的任何资料。

七、受试者损伤的处理

如果您因参与这项研究而受到伤害，您将获得及时的治疗，由此所增加的诊治费用和造成的损害，将根据中国法律规定获得相应的赔偿。

八、其他

本研究将不提供任何治疗措施，您的诊断和治疗将由研究医生根据常规实践自行判断，您可以继续维持本来的常规治疗方案。

本次研究相关信息以及知情同意书已通过本研究机构伦理审查委员会审查。试验过程中有任何违反研究方案的情况，您可以直接向广州市第十二人民医院伦理委员会投诉。联系电话：020-38981249。

如果自愿参加本研究，您需要签署知情同意书证明您已经了解研究的信息并自愿参加本项研究。

附录 6

广州市第十二人民医院医学伦理委员会
生物医学研究项目伦理审批件

第(2024020)号

项目名称	反流性食管炎中医证型分布特点及相关因素分析				
项目类别	基础	临床	公共卫生	药物	
研究部门	广园内科	项目负责人	范路娣	职 称	主治医师
伦理审查意见					
△ 同意				√	
△ 修改后同意					
△ 不同意 (项目终止或暂停)					
审批意见					
该论文对经胃镜诊断为反流性食管炎病例进行中医证型分布调查及相关发病因素的挖掘，以期通过饮食起居调护对相关发病因素干预，为降低 RE 的发病率奠定基础同时为临床更合理选方用药提供参考。研究符合法律法规，研究方案科学，符合伦理原则，研究者的资格、经验、技术能力等符合研究要求，受试者不会因本研究遭受额外风险或收到损害，受试者招募方式、途径、纳入和排除标准恰当，受试者参加研究的合理支出可以得到合理补偿；受试者信息及相关资料的保密措施充分，招募合理，知情同意规范，有具备资格或者经培训后的研究者负责获取知情同意，并随时接受有关安全问题的咨询，向受试者明确告知其应当享有的权益，包括在研究过程中可以随时无理由退出且不受歧视的权利等，研究不涉及利益冲突。请项目负责人保留知情同意书签署资料以备后续跟踪审查。 委员会同意发表该论文。					
广州市第十二人民医院医学伦理委员会 主任委员签字：  (盖章) 2024 年 2 月 21 日					

附 录 7

英文缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
TCM	Traditional Chinese Medicine	中医
RE	Reflux esophagitis	反流性食管炎
GERD	gastroesophageal.reflux.disease	胃食管反流病
BE	Barrett's esophagus	巴雷特食管
IL-17	Interleukin-17	白细胞介素 17
IL-23	Interleukin-23	白细胞介素 23
MTL	Motilin	胃动素
CGRP	Calcitonin gene-related peptide	降钙素基因相关肽